Ghid de practica clinică de chirurgie minor
în asistență medicală primară

booksmedicos.org

AUTORI
M. Paz Blanco Franco
Pediatru al/a/ale Centru de Sănătate de Villablino. Leu
Emilia Bruzos González
Asistentă medicală al/a/ale Centru de Sănătate de Villablino. Leu
Luis Arthur Canedo Canedo
Asistentă medicală al/a/ale Centru de Sănătate al/a/ale Pod duminică Florez. Leu
M. Ángeles González Fernández
Responsabil de Asistență medicală de Echipe de cel/cea/cei/cele Management de Atenție Primar El Bierzo. Leu
M. Fernanda Martinez Quiroga
Doctor de Familial al/a/ale Centru de Sănătate Ponferrada II. Leu
Ana Isabela Martinez Villanueva
Doctor de Familial al/a/ale Centru de Sănătate de Villafranca al/a/ale Bierzo. Leu
Jose Antonio Munte Subțire
Doctor de Familial al/a/ale Centru de Sănătate de Toreno. Leu
Confort Pol Carballo
Doctor de Familial al/a/ale Centru de Sănătate de Cacabelos. Leu
Petru Manuel Sanchez Ingelmo
Asistentă medicală al/a/ale Centru de Sănătate de Bembibre, León
M. Dolores Vázquez Colinas
Asistentă medicală al/a/ale Centru de Sănătate Ponferrada I. León
Ioan Garcia Antonio.
Chirurg responsabil de chirurgie minor al/a/ale Zonă de Sănătate El Bierzo. Leu

RECENZORI EXTERN
Rosana al/a/ale Iubesc López
Societate Spaniolă apă Leoaică de Medicament de Familial apă Comunitate (SOCALEMFICĂ)
Rabwan Abou-Assali Boasly
Societate Spaniolă de Medicament General (SEMG)
Iosif Fierar Roa
Societate Spaniolă de doctori de AP (SEMERGEN)
Pilar Trigueros Aguado
Asociere de Asistență medicală Comunitate

COORDONARE
Esther Merayo Fernández
Director de Asistență medicală de cel/cea/cei/cele Management de Atenţie Primar El Bierzo. Leu
Serviciul de programe de asistență
Adresa General de Prezență Sănătate

© Junta de Castilla și León
Management Regional de
Sănătate
Realizare editorial: Management Regional de Sănătate
Depozit legal:
Imprimare:

Ghid de practica clinică de chirurgie minor
în asistență medicală primară

Mulțumirile noastre către

Mercedes González Garcia, Tehnic de Sănătate al/a/ale Zonă din Palencia
de lui opinie despre el domeniu de aplicare de Acest ghid.

LA Alser González Martinez, Profesor de Limbă Spaniolă,
de cel/cea/cei/cele revizuire lingvistică al/a/ale text

LA noastre familii
de către el timp că Nu ei avem dedicat

LA noastre tovarăși de cel/cea/cei/cele
Echipe de lui efort în cel/cea/cei/cele sarcină sănătate în timpul
absențele noastre

PREZENTARE 13

1 INTRODUCERE 15
Justificare. 15
Obiective de cel/cea/cei/cele Ghid. 15
Elaborare de cel/cea/cei/cele Ghid. 16

2 THE CHIRURGIE MINOR ÎN ATENŢIE PRIMAR. 19
Definiţie. 19
Avantaje de cel/cea/cei/cele implantare de cel/cea/cei/cele chirurgie minor în Atenţie Primar. 19
Populaţie Diana. 20
Criterii de includere 20
Criterii de Excludere. 20
Situaţii oferte speciale: pacienţi anticoagulat Eu agenţi antiplachetari. 21
Activităţi. 21
Algoritm de performanţă. 25

3 PROCEDURI ÎN CHIRURGIE MINOR. 27
Aspecte Generali 27
Igienă chirurgical 27
Pregătire al/a/ale domeniu chirurgical 27
Anestezie 28
31 de suturi .....
Proceduri chirurgical Noţiuni de bază. 34
Excizie de răni superficial 34
Îndepărtare de răni subcutanat. 36
Incizie şi drenaj de abcese cutanată. 37
Chirurgie unghiilor 38
Extracţie granulom de corp străin 41
Reconstrucţia unui lob al urechii rupt 41
Chirurgie distructivă a leziunilor superficiale 43
Urmare şi tratamente postoperatoriu 46
Îngrijirea postoperatorie a plăgii chirurgicale. 46
Analgezie. 47
Profilaxia antibiotică 47
Canalizare 47
Îndepărtarea suturilor 47
Complicaţii postoperatorii 48
Planuri de îngrijire standardizat 51

4 EVALUARE AL/ALE GHID. 57

5 ANEXE. 59

Expoziţie YO: Pregătire pentru proceduri invaziv minori la pacienții aflați sub tratament cu anticoagulante orale Eu agenți antiplachetari trombocite. 59

Expoziţie II: Anamneză Preoperator. 60

Expoziţie III: Informații preliminare către intervenție chirurgicală 61

Expoziţie IV: Document de consimțământ informat 63

Expoziţie V: Trimitere către serviciu de intervenții chirurgicale minore 64

Expoziţie VI: Foaie de intervenție. 65

Expoziţie VII: Foaie informativ pentru pacient după al/a/ale intervenție 66

Expoziţie VIII: Protocol colectare și transport maritim de mostre la Anatomie Patologic. 67

Expoziţie IX: Foaie de cerere studiu la Anatomie Patologic (Mod.) AP -45) 68

Expoziţie X: Curățenie şi sterilizare al/a/ale instrumental 69

Expoziţie XI: Caracteristici al/a/ale anestezice localnici 70 cele mai utilizate.....

Expoziţie XII: Infrastructură pentru cel/cea/cei/cele practica de intervenții chirurgicale minore în Atenţie Primar 71

6 BIBLIOGRAFIE. 75

ABREVIERI

Atenţie AH Spital
Atenţie AP Primar
Chirurgie CM Minor
Centrul CS de Sănătate
EAP Echipament de Atenţie
Primar Managementul decalajelor de
Atenţie Primar Managementul medicilor
de familie de Procese
Ghid GPC de Practica Clinică
Istoricul HC Clinică
NANDA Nord Diagnosticul medical american Asociere
Placă de reţea Asistenţă medicală Intervenţie
Clasificare
Asistenţă medicală NOC Rezultate
Clasificare RCP Resucitación
Cardiopulmonar

PREZENTARE

Cu cel/cea/cei/cele scop de crește cel/cea/cei/cele accesibilitate și cel/cea/cei/cele calitate de cel/cea/cei/cele servicii de sănătate la populația, cel/cea/cei/cele chirurgie minor a fost inclusiv ca beneficia sănătate al/a/ale NHS în el domeniu de aplicare de Atenție Primar în 1995. El Real Decret 1030/2006, de 15 de Septembrie, care stabilește cel/cea/cei/cele servietă de servicii comun al/a/ale Sistem Național de Sănătate include cel/cea/cei/cele intervenții chirurgicale minore în cadrul serviciilor de Asistența medicală primară, care include efectuarea procedurilor terapeutic fie diagnostice de scăzut complexitate și minim invaziv , cu scăzut risc de hemoragie, că EL practica scăzut anestezie local și că ei nu necesită îngrijire postoperator, în pacienți că Nu au nevoie venituri, conform la protocoalele stabilite și organizarea fiecărui serviciu sanitar.

În Castilia și Leon, intervențiile chirurgicale minore fac parte din activitatea obișnuit de cel/cea/cei/cele Echipe de Atenție Primar, deși când lui Organizația trebuie să se adapteze local la fiecare context din fiecare dintre Domeniile de Sănătate. Deși este o activitate consolidată, este oportun și relevant să se stabilească ghidurile științifice și tehnice și procedurile generale, precum și să se actualizeze și să se modernizeze criteriile de calitate, precum și să se standardizeze toate activitățile de îngrijire și asistență care vizează efectuarea intervențiilor chirurgicale minore în asistența medicală primară . Acest este el scop că EL urmărește cu cel/cea/cei/cele publicare de acest ghid, în cel/cea/cei/cele că, În orice caz, procedurile chirurgicale au fost incluse în activitatea de asistență medicală a centrelor de sănătate.

Acest ghid se supune la cel/cea/cei/cele răspuns favorabil că Ha a avut cel/cea/cei/cele implantare de cel/cea/cei/cele intervenții chirurgicale minore în asistența medicală primară, oferind profesioniștilor o capacitate mai mare decisiv, îmbunătățirea relația medic-pacient și sporindu-i prestigiul, cu siguranță, performanța de cel/cea/cei/cele profesioniști de Atenție Primar, atâta al/a/ale doctor de familial (fie pediatru), ca de cel/cea/cei/cele asistentă medicală. Formă parte de o proiect mai departe global, în el că EL include pregătirea de ghizi de practica clinică, ca instrument de ajuta clinică, inițierea de aceste procese că de lui ridicat incidență fie prevalență sunt frecvente și în fiecare zi în cel/cea/cei/cele activitate al/a/ale profesional de Atenție Primar.

În dezvoltarea sa, criteriile de siguranță a pacientului au fost luate în considerare mai presus de toate . eficacitate și calitate om de știință tehnică. Constituie o ajuta pentru el profesionist din Asistența medicală primară și are, de asemenea, un impact pozitiv asupra satisfacției utilizatorilor față de asistența medicală primară.

Pe scurt, este un instrument valoros pentru profesioniști, conceput de o grup de profesioniști cu larg experiență în chirurgie minor, la cel/cea/cei/cele pe care o vrem mulțumesc lui dedicare, în special către grup de post al/a/ale Zonă din Ponferrada, precum și tuturor profesioniștilor din societățile științifice care ei au a participat, direct fie ca recenzori, în cel/cea/cei/cele prezent ghid.

Francisc Javier Alvarez Guisasola
Consilier de sănătate de acolo Junta de Castilla și León

1 INTRODUCCIÓN

JUSTIFICARE

Cel/Cea/Cei/Cele elaborare de acest ghid EL justifică de cel/cea/cei/cele existenţă de patologii susceptibil de fi rezolvat prin tehnici de chirurgie minor (CM) în Asistenţă medicală primară (AP).

Existenţa unui Ghid de Practică Clinică (GPC) în MC va oferi avantaje importante profesioniştilor, ghidându-i în gestionarea optimă a acestor probleme. proceduri, Aşa ca în cel/cea/cei/cele utilizare potrivit de cel/cea/cei/cele resurse sanitar disponibil. Cel/Cea/Cei/Cele utilizatori EL va beneficia de o Atenţie omogen şi de calitate contrastate. În afară de pentru el sistem sanitar EL va converti în un serviciu foarte eficient.

Acest ghid este destinat tuturor profesioniştilor implicaţi în diferitele activităţi implicate în desfăşurarea CM-ului la Centrul Sa. lud (CS):

- Doctori.
- Pediatri.
- Asistente medicale.
- Asistenţi de asistenţă medicală.

OBIECTIVE DE THE GHID

Scop General

Dotare la cel/cea/cei/cele profesionişti de Asistenţă medicală primară de o instrument util pentru cel/cea/cei/cele lua de decizii către plan şi executa cel/cea/cei/cele chirurgie minor , cu el Sfârşit de că EL transforma într-un serviciu de calitate care depăşeşte aşteptările utilizatorilor.

Obiective Specificităţi

1. Stabili cel/cea/cei/cele criterii de includere şi excludere.
2. Enumera cel/cea/cei/cele diferit activităţi la transporta la pelerină.
3. Pentru a standardiza toate acele activităţi de îngrijire şi sprijin care vizează realizarea CM în AP.
4. Propune unele criterii că S.U.A permite evalua cel/cea/cei/cele aplicaţie şi utilitatea ghidului.

ELABORARE DE THE GHID

Acest ghid de practica clinică în chirurgie minor Ha fost pregătit de profesioniști din domeniul sănătății , medici și asistente medicale, care alcătuiesc grupul de management de Procese (medic generalist) de cel/cea/cei/cele Management de Atenție Primar (DECALAJ) al/a/ale Zona Bierzo și persoana responsabilă de chirurgia minoră din zonă.

Acest grup, format în 2005 pentru a promova Metodologia de Management de Procese, la exemplu de cel/cea/cei/cele Adresa General de Prezență Sanitar, a început pregătirea acestui ghid în 2006.

A fost elaborat un prim proiect de document care, după ce a fost prezentat și validat în cadrul Comisiei Zonale pentru Calitate în decembrie 2006, a fost trimis Direcției Tehnice de Asistență Medicală Primară, care l-a înaintat societăților științifice enumerate mai jos:

- SocalemFYC (Societatea Castiliană și Leoneză de Medicină de Familie și Comunitară).
- SEMG (Societate Spaniolă de Medici Generali și de Familial).
- SEMERGEN (Societate Spaniolă de Medici de Atenție Primar).
- Asociere de Asistență medicală Comunitate.
- Societate Spaniolă de Asistență medicală Familiar și Comunitate.

Acest document, care conține noua versiune a ghidului, include recomandările formulate de aceste societăți științifice.

Fotografiile incluse au fost obținute de autori în cadrul diferitelor intervenții efectuate, cu excepția celor care corespund următoarei numerotări :

- 4.5.8.10.13.15, originar de "Chirurgie Minor și Proceduri în Medicină de familie". Autor José Mª Arribas Blanco. Jarpyo Editores SA Madrid 2000.
- 7. Suturi, originar de "Manual de suturi." Zonă științific Menarini. Publicat de Laboratoarele Menarini, SA www.formacionsanitaria.com.

Cel/Cea/Cei/Cele membri al/a/ale grup de elaborare de cel/cea/cei/cele ghid, declara Nu suporta în niciun caz posibil conflict de interese. Nici unul Ha primit remunerație al-guna pentru participarea lor la acest proiect.

Acest ghid EL Ha făcut ca document de sprijin către Proces de Chirurgie minoră în asistența medicală primară, elaborat de același grup de lucru.

Conţinutul său ar trebui revizuit şi actualizat periodic pentru a aduna informaţiile inovaţii derivate de cel/cea/cei/cele constant evoluţie de cel/cea/cei/cele practica şi el cunoştinţe clinicieni. El grup dezvoltator ia în considerare valabil o perioadă de patru ani pentru primul lor control.

LA CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA

2

1. DEFINIŢIE

Cel/Cea/Cei/Cele chirurgie minor include o serie de proceduri chirurgical proceduri simple şi de scurtă durată, efectuate pe ţesuturi superficiale sau structuri uşor accesibile, sub anestezie locală şi cu risc redus, în care nu se aşteaptă complicaţii majore intra- sau postoperatorii şi care sunt susceptibile de a fi asumat cu cel/cea/cei/cele mass-media disponibil în îngrijire Primar.

Procedimientos incluidos en CM en AP

- Exéresis de lesiones cutáneas superficiales no sospechosas de malignidad.
- Extirpación de lesiones subcutáneas.
- Incisión y drenaje de abscesos cutáneos.
- Cirugía ungueal.
- Extracción de granuloma por cuerpo extraño.
- Reconstrucción desgarro lóbulo pabellón auricular.
- Cirugía destructiva de lesiones superficiales (criocirugía y electrocirugía).

2. AVANTAJE DE THE IMPLANTAŢIE DE THE CM ÎN AP

Rezolvarea patologiilor prin aplicarea tehnicilor de CM în asistenţa medicală primară oferă avantaje importante utilizatorilor, profesioniştilor şi sistemului de sănătate în sine:

- Cel/Cea/Cei/Cele utilizatori ei obţin o tratament potrivit la lor nevoi în un mediu mai departe accesibil, cu foarte puţini întârzieri şi fără călătorii inutile .

- Cel/Cea/Cei/Cele profesionişti sanitar de AP de obicei percepe acest activitate ca un factor de motivaţie profesională datorită capacităţii lor sporite de rezolvare a problemelor, consolidării relaţiei cu pacienţii şi diversificării practicii lor zilnice.

- Pentru sistemul de sănătate, rezultatul bun al acestei intervenţii chirurgicale, care este mai puţin costisitoare decât tratamentele spitaliceşti, o face un serviciu medical valoros . de eficienţă contrastat, uşurare cel/cea/cei/cele presiune şi liste de aşteptaţi la alte niveluri de îngrijire.

3. POPULAȚIE DIANA

Toate cel/cea/cei/cele oameni al/a/ale Zonă de Sănătate.

4. CRITERII DE INCLUDERE

Pacient care prezintă oricare dintre patologiile susceptibile de a fi tratate prin tehnici CM.

Patologías susceptibles de ser tratadas con CM en AP

- Lesiones cutáneas no sospechosas de malignidad (verrugas, papilomas, fibromas, nevus...)
- Lipomas.
- Quistes epidérmicos.
- Onicocriptosis (uñas incarnadas).
- Onicogrifosis.
- Cuerpo extraño en piel y tejido subcutáneo.
- Abscesos.
- Desgarro en el lóbulo del pabellón auricular.

5. CRITERII DE EXCLUDERE

Nu ei trebuie fi asumat în AP cel/cea/cei/cele următorul presupuneri:

- Când cel/cea/cei/cele răni depăşi cel/cea/cei/cele epidermă în zone anatomic de risc ridicat (regiunea parotidă, arcada zigomatică, regiunea retroauriculară, marginea internă) al/a/ale cot, faţă fost al/a/ale cot, faţă ventral de cel/cea/cei/cele păpuşă, pleoape etc.)
- Contextul alergie la cel/cea/cei/cele anestezice localnici folosit de obicei.
- Suspiciune de malignitate a vătămare.
- Fundal de cicatrici cheloide.
- Existenţă de coagulopatii.
- Prezenţa unor patologii cronice necompensate sau insuficient studiate .
- Pacienţi terminale.
- Absenţă de consimţământ informat.

- Boală vasculară periferică severă pentru practicarea chirurgiei unghiilor în AP.

- Patologii că încă ființă susceptibil de include în el serviciu, datorat la al lui dimensiune fie extensie EL sfătuiește deriva la Atenție Spital (AH).

6. SITUAȚII OFERTE SPECIALE

Pacienți anticoagulat Eu medicamente antiplachetare

Administrarea de anticoagulante orale sau medicamente antiplachetare nu înseamnă O contraindicație la programarea unei intervenții de medicină complementară în cadrul asistenței medicale primare. Întreruperea administrării acestor medicamente înainte de [intervenție] trebuie luată în considerare. la cel/cea/cei/cele chirurgie, conform cel/cea/cei/cele model colectare în Anexa YO.

7. ACTIVITĂȚI

A. Bazin hidrografic

Consultație din partea pacientului și/sau a tutorelui, cu privire la o patologie care poate fi tratată cu CM fie găsi casual de parte al/a/ale sanitar.

B. Evaluare Inițială

Diagnostic inițială de cel/cea/cei/cele patologie și evaluare de cel/cea/cei/cele indicație de CM în AP.

C. Informații Către Pacient

Pacientul și/sau tutorele, în cazul unui minor sau al unei persoane-Pacienții cu deficiențe cognitive vor fi informați, folosind un limbaj ușor de înțeles, atât despre patologia detectată, cât și despre posibilitatea abordării acesteia prin tehnici de CM efectuate chiar în Centrul de Sănătate.

D. Anamneză Preoperator

În cazul în care pacientul este de acord cu rezolvarea patologiei sale în AP Se va realiza un chestionar pentru a detecta prezența unor presupuneri care îl contrazic (Anexa II).

E. Livrare De Cel/Cea/Cei/Cele Foaie Ştiri ŞI Dintre Model De Consimțământ Informat

Se pare că de neiertat pentru toate intervenție cel/cea/cei/cele obținerea al/a/ale consimțământ informat expres al/a/ale pacient fie de cel/cea/cei/cele părinți/tutori juridic de cel/cea/cei/cele minori și incapabil. Cel/Cea/Cei/Cele cerințe juridic ei cer lui obținerea de scris și după

să ofere pacientului informaţii detaliate despre toate aspectele care i-ar putea influenţa decizia.

Este recomandabil să se suplimenteze informaţiile verbale prin furnizarea unui document scris . de informaţii chirurgical general (Foaie informativ previzualizare la cel/cea/cei/cele intervenţie. Anexa III).

Se va furniza documentul de consimţământ informat (anexa IV), care va clarifica că EL tratează de o premisă medico-legal fără cel/cea/cei/cele care Nu EL poate a duce la pelerină cel/cea/cei/cele intervenţie. EL va explica că EL trebuie să citire cu arestare şi EL va arăta disponibilitatea noastră pentru a clarifica orice îndoială că propune.

F. Derivare Către Serviciu de CM

Profesionistul care solicită intervenţia trebuie să transmită Fişa de trimitere (Anexa V) echipei/responsabilului CM, prin intermediul zonei administrative.

G. Programare De Cel/Cea/Cei/Cele Intervenţie

El responsabil al/a/ale serviciu de CM al/a/ale Echipament de Atenţie Primar (EAP) va primi şi va valora cel/cea/cei/cele Foaie de derivare cu el Sfârşit de plan cel/cea/cei/cele ordinea de zi al/a/ale serviciu , atribuind data şi ora intervenţiei.

Planificarea agendei va lua în considerare o serie de criterii de oportunitate pentru optimizarea resurselor disponibile:

- Urgenţă de cel/cea/cei/cele intervenţie.
- Durată de intervenţiile .
- Afinitate de patologii.
- Chirurgie murdar după chirurgie curat (nu către verso).

H. Citare Dintre Pacient

Cel/Cea/Cei/Cele servicii administrativ al/a/ale CS va comunica către pacient el zi şi cel/cea/cei/cele timpul alocat pentru cel/cea/cei/cele intervenţie, amintindu-i că trebuie să aduce semnat el documentul de consimţământ informat.

I. Recepţie ŞI Intervenţie Dintre Pacient

- ID-ul al/a/ale pacient.
- Prezentare al/a/ale echipament chirurgical.
- Evaluare de cel/cea/cei/cele patologie şi testare de cel/cea/cei/cele adecvare de cel/cea/cei/cele circumstanţe clinici al/a/ale pacient. În caz de respinge cel/cea/cei/cele intervenţie:
  - EL va aranja o nou numire.
  - EL va deriva de nou la medicul dumneavoastră .
- Realizare al/a/ale procedură chirurgical.
- Informaţii la cel/cea/cei/cele familial despre de cel/cea/cei/cele intervenţie.

J. Finalizare De Cel/Cea/Cei/Cele Foaie De Intervenţie

În scopuri clinice, evaluative, didactice şi medico-legale, este recomandabil să se ţină o evidenţă de intervenţii comun pentru toate el echipament. Acesta mai departe funcţional este dispută de o "Carte de Intervenţii" în cel/cea/cei/cele sală de chirurgie unde EL colecta datele minime de fiecare intervenţie: Date de cel/cea/cei/cele profesionişti, date al/a/ale pacient , data de cel/cea/cei/cele intervenţie, incidente intraoperator… El carte va avea de frunze autocopiere de mod că o de cel/cea/cei/cele copii va rămâne în el în timp ce că cel/cea/cei/cele alte voi intenţionat la lui arhivă în cel/cea/cei/cele Istorie Clinică (HC) al/a/ale pacient.

K. Livrare Dintre Plan De Îngrijire Postoperator

La finalul procedurii, pacientul şi/sau membrii familiei vor fi informaţi, verbal şi/sau în scris (Anexa VII), cu privire la recomandările postoperatorii. care trebuie urmate pentru o recuperare optimă:

- Îngrijire de sine.
- Tratament farmacologic că continuaţi.
- Model de cel/cea/cei/cele primul revizuire.

L. Aplicaţie De Studiu Patologie anatomică

1. Livrare mostră :

Dacă este necesar un studiu anatomopatologic, proba va fi trimisă la Serviciu de Anatomie Patologic, observarea cel/cea/cei/cele reguli stabilit în protocolul de colectare şi expediere de mostre (Expoziţie VIII). Cel/Cea/Cei/Cele eşantion voi însoţit de Formularul de cerere de studiu Anatomie patologică (Anexa IX).

2. Recepţie al/a/ale raport:

După cel/cea/cei/cele recepţie al/a/ale raport al/a/ale studiu anatomopatologic, el doctor va informa pacientul despre rezultat. Dacă raportul patologic corespunde la o patologie Nu abordabil în AP EL va trimite pentru lui evaluare la AH.

M. Întreţinerea Camerei de Intervenţie E CM Instrumental

După cel/cea/cei/cele intervenţie EL va continua la cel/cea/cei/cele curăţenie de cel/cea/cei/cele sală de CM, recuperarea tot materialul consumabil utilizat în timpul aceeaşi.

El instrumental EL va curăţa şi va steriliza conform protocol (Expoziţie X).

N. Urmare Dintre Pacient

În funcţie de patologia tratată şi de tehnica utilizată, medicul va programa controale ulterioare.

O. Ridicat ŞI Înregistra În Cel/Cea/Cei/Cele Istorie Clinică

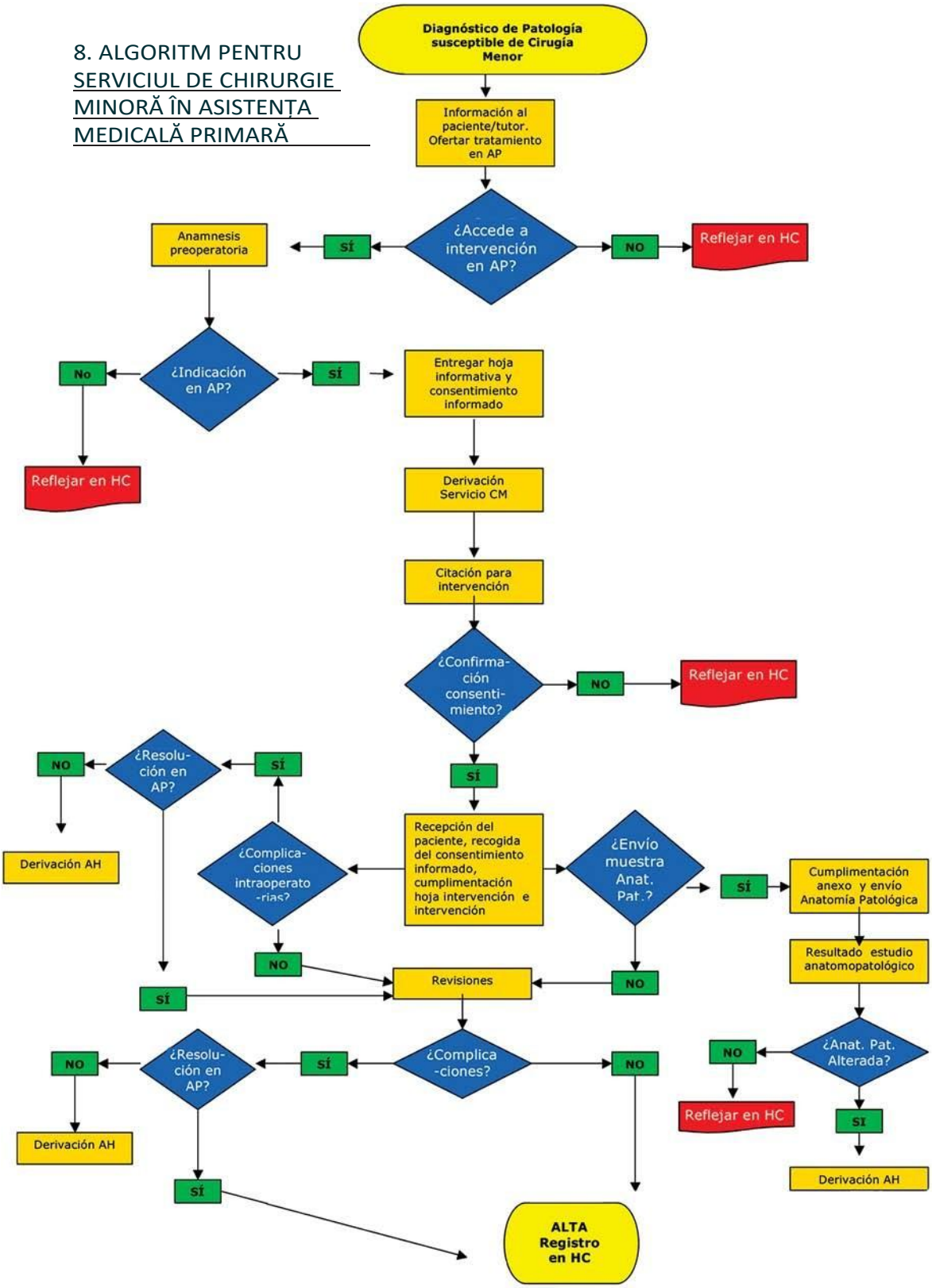
Odată rezolvată patologia care a dus la includerea în serviciul CM şi orice

posibile complicații, pacientul va fi externat.

În cel/cea/cei/cele foaie de evoluţie de cel/cea/cei/cele istorie clinică, EL se va înregistra toate cel/cea/cei/cele Activităţi desfăşurate de la prima consultaţie (motivul consultaţiei, examinare, teste complementare, impresie diagnostică…), până la externarea din cauza vindecării (inclusiv îngrijirile postoperatorii, dacă acestea au fost necesare) sau cel/cea/cei/cele derivare la Atenţie spital de orice de cel/cea/cei/cele motive aşteptat. ei/ele vor colecta în cel/cea/cei/cele istorie clinică al/a/ale pacient toate cel/cea/cei/cele documente genă-rados ca consecinţă de lui includere în el serviciu de chirurgie minor:

- Anamneză preoperator.
- Consimţământ informat.
- Copie de cel/cea/cei/cele foaie de Intervenţie.
- Raport de anatomie patologic.

8. ALGORITM PENTRU SERVICIUL DE CHIRURGIE MINORĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ



PROCEDIMIENTOS EN CIRUGÍA MENOR 3

1. ASPECTE GENERAL

A. Igienă Chirurgical

Obiectivul principal al asepsiei în chirurgie este de a preveni infectarea plăgii chirurgicale. Pentru acesta EL necesitate respect anumit precauţii universale de protecţie în toate intervenţiile.

Chiar dacă în timpul procedurii se foloseşte doar un halat de examinare simplu, curat, dar nu steril (pentru a proteja pielea şi îmbrăcămintea de fluidele organice sau soluţiile dezinfectante), trebuie utilizate fără excepţie mănuşi sterile şi o mască. şi ochelari de protecţie pentru a proteja pielea şi mucoasele de stropii accidentali. Dacă se tratează un purtător cunoscut de hepatită sau HIV, utilizarea mănuşilor duble reduce inoculul la jumătate în cazul unei leziuni prin înţepare cu ac.

Cel/Cea/Cei/Cele corecta plasare de cel/cea/cei/cele mănuşi, joc numai lui parte interior ca să nu pauză cel/cea/cei/cele sterilitate extern, trebuie să fi precedat de o spălat de Mâinile cu săpun chirurgical. În CM, frecarea chirurgicală convenţională până la antebraţ nu este necesară. Pur şi simplu frecaţi întreaga suprafaţă a mâinilor. către Mai puţin trei ori în o perioadă de două minute ("rutină de „Ayliffe") Ajunge .

B. Pregătire al/a/ale domeniu chirurgical

1. Pregătirea pielii

- Blană fără păr:
  - Curat cu soluţie salină fiziologic şi uscat cu şifon steril.
  - Perie cel/cea/cei/cele zonă la interveni cu tampon de şifon, montat în clemă din Pean, impregnat în antiseptic de alegere: povidonă iodat 10% sau clorhexidină, prin o mişcare în spirală din el centru la periferia, acoperind o suprafaţă mai mare decât orificiul unei pânze fenestrate .

- Blană cu păr:
  - Tăiaţi el păr la ras de blană cu o foarfece de mai şi numai în cel/cea/cei/cele zonă al/a/ale intervenţie. Retrage cel/cea/cei/cele fire de păr tăiat ne ajută de hârtie adeziv (bandă adezivă sau folie alimentară). Imobilizaţi orice păr rămas care vă deranjează cu vaselină sau bandă adezivă.

  - Evita el bărbierit. Da este esenţial, purta o maşini de tuns De unică folosinţă, fără a zgâria pielea. Nu radeţi sprâncenele.

• Apoi, procedaţi în acelaşi mod ca pe pielea fără păr. scris mai sus.

1. Campo quirúrgico delimitado con paño fenestrado

2. Pañeado del campo quirúrgico

- Colocar un paño fenestrado de papel impermeable estéril y desechable, preferiblemente adhesivo a la piel para fijarlo, haciendo coincidir la abertura con la zona cutánea a intervenir.

- En su defecto, delimitar la zona a intervenir ordenando en torno a ella varios paños estériles normales ayudándonos de pinzas de campo.

3. Exposición del instrumental estéril

Sobre una superficie auxiliar, preferiblemente mesilla con ruedas, se coloca un paño estéril normal y se deja caer sobre él directamente de los envases protectores el material previsto para la intervención que va a ser usado de forma inmediata evitando su contaminación.

No se debe emplear el instrumental contenido en bolsas abiertas o rotas.

1. Instrumental cirugía ungeal

2. Instrumental cirugía general

Anestezie

Utilizarea anestezicelor locale permite controlul complet al durerii în timpul intervenţiei chirurgicale. Trei modalităţi pot fi utilizate pentru practicarea CM în AP. de anestezie: de actualitate, infiltrare local şi el blocadă foarte nervos (trunchi).

1. Anestezie topică

Este util pentru anestezia o mic zonă de blană fie membrană mucoasă.

Sunt în el piaţă pregătit specific pentru diferit Utilizări:

- Aerosol cutanat cu lidocaină 10%: Aplicaţi 3-5 pulverizări pe zona afectată, iar perioada de latenţă este de 3-5 minute.
- Cremă EMLA (amestec de lidocaină 2,5% şi prilocaină 2,5%) aplicat cu o pansament ocluziv plastic 45-90 minute înainte al/a/ale Această procedură este eficientă pentru intervenţia directă pe zone mici de piele (mai puţin de 5x5 cm).
- Spray-uri răcoritoare cu clorură de etil: Acestea oferă anestezie cutanată pe termen scurt prin frig, suficientă pentru proceduri superficiale şi rapide (ras, puncţii etc.). Se aplică mai multe pulverizări până când zona devine albicioasă, moment în care se poate efectua procedura.

2. Anestezie locală prin infiltrare

El agent anestezic EL infiltrare extravascular în cel/cea/cei/cele ţesuturi cutanat şi subcutanat de cel/cea/cei/cele zonă la interveni prin mai multe Injecţii. Funcţionează. inhibând excitaţia terminaţiilor nervoase.

EL de obicei utilizare anestezice al/a/ale tip amino-amide de lui minor potenţial alergenic (Anexa XI):

- Lidocaină, de scăzut putere şi acţiune scurt.
- Mepivacaină către 1 fie 2%, cel/cea/cei/cele mai departe folosit de lui putere şi durată intermediar.

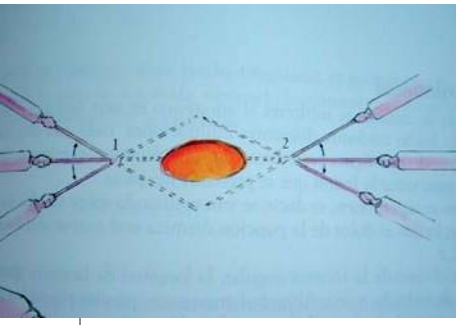
Cantitatea necesară depinde de amploarea şi durata procedurii, dar nu trebuie depăşită niciodată doza maximă.

Putem folosi anestezic cu vasoconstrictor (adrenalină 1:100.000) în acele procese care sângerează mult, ţinând cont de faptul că în acest caz debutul efectului este mai lent, dar şi mai prelungit.

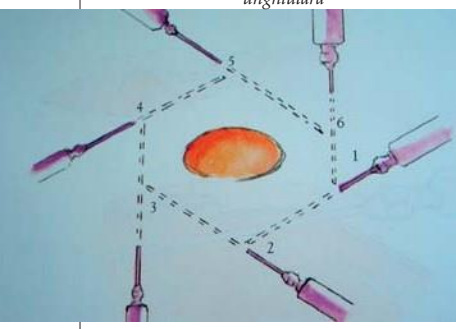
Utilizarea sa ar fi contraindicată pe degete, nas, ureche, penis şi pe acele zone marginale ale pielii cu risc de necroză.

Tehnica de infiltrare

Cel/Cea/Cei/Cele primul străpungere EL performează introducerea o ac de insulină perpendicular la cel/cea/cei/cele blană. EL formă aşa o primul haban dermal fie subdermal cu 1-2 cc de anestezic. A Din acel moment se efectuează infiltrarea subcutanată . pentru acesta că EL poate utilizare o ac mai departe lung introdus la prin a bobului iniţial.



4. Tehnica de infiltrare unghiulară



5. Tehnica de infiltrare perifocală

Această a doua infiltrare se poate face în trei moduri, în funcţie de leziune:

- Liniară cu puncte suprapuse: fiecare infiltrare se realizează în urma celei anterioare.
- Angular: cu o numai înţepătură EL distribuie el anestezic pe zone într-un model asemănător evantaiului.
- Perifocal: efectuarea mai multor puncţii în jurul leziunii.

Pentru fiecare inserţie a acului, întreaga lungime trebuie utilizată pentru infiltrare pe măsură ce acul este avansat sau retras. În acelaşi timp, la fiecare introducere a acului, trebuie să aspirăm pentru a ne asigura că nu am perforat un vas de sânge.

3. Bloc nervos (anestezie trunchială)

EL injectează el anestezic în unele loc al/a/ale călătorie al/a/ale nerv cutanat că inervaţie cel/cea/cei/cele zonă. Are cel/cea/cei/cele avantaj de că scade cel/cea/cei/cele umflare de cel/cea/cei/cele zonă şi el efect este mai departe durabil, dar de el contrar poate să se întâmple o deteriora neural Drept şi el efect anestezic EL ia mai departe timp în ajunge.

Această metodă este utilizată în blocurile digitale: anestezicul este infiltrat fără vasoconstrictor prin o ac amenda în cel/cea/cei/cele faţă parte de cel/cea/cei/cele falangă proximal a degetului, sosirea către periost şi infiltrare primul el plat adânc, repetând Procesul se repetă şi pe cealaltă parte a degetului. În acest caz, efectul durează 10-15 minute.

6 a şi b. Tehnică infiltrare trunchi în deget

4. Consideraţii general despre cel/cea/cei/cele anestezie în CM

- Explica către pacient el procedură şi întreabă-l de posibil alergii.
- Purta o seringă potrivit pentru cel/cea/cei/cele ac că haide la utilizare.
- Transporta personal cel/cea/cei/cele seringă cu el anestezic.
- Aspira înainte de injecta.
- Menţineţi contactul verbal şi vizual continuu cu pacientul pentru a detecta din timp reacţiile adverse.
- Aşteaptă între 10 şi 15 min. pentru început cel/cea/cei/cele intervenţie. Cel/Cea/Cei/Cele cauza mai departe O cauză frecventă a eşecului efectului anesteziei este nerăbdarea.
- A avea întotdeauna dispus el echipament de resuscitare cardiopulmonar (RCP).

C. Suturi

În cel/cea/cei/cele cele mai multe de cel/cea/cei/cele proceduri că noi performăm în chirurgie minor am terminat el act chirurgical bun cauterizare cel/cea/cei/cele zonă sângerare cu scalpel electrică sau cu o sutură chirurgicală.

După ce am stabilit conceptul că sutura este aproximarea ţesuturilor cu aceleaşi caracteristici pentru ca acestea să se vindece corect, reamintim principiile generale ale suturii în chirurgia minoră. :

- Reduceţi tensiunea de pe rană înainte de a o închide prin disecţie dermo-adipoasă cu foarfeca sau bisturiul.
- Straturi apropiate în cazul rănilor adânci sau în cazul spaţiilor moarte.
- Aplică cel/cea/cei/cele încordare potrivit pentru faţă cel/cea/cei/cele ţesuturi fără ischemice.
- Obţine o bun eversiune de cel/cea/cei/cele margini.
- Loc el număr minim de puncte că obţine o bun aproximaţi marginile şi eliminaţi spaţiile moarte.
- Cel/Cea/Cei/Cele tehnică de înnodat de alegere în chirurgie minor este cel/cea/cei/cele instrumental, cu titular ace şi ace curbe, că presupune cel/cea/cei/cele primul lasso dubla (nod) de chirurg) şi cel/cea/cei/cele următorul lasso în sens contrar la cel/cea/cei/cele fost întărind-o şi fără crea creşte de încordare. El nod EL va pleca la unul de părţile laterale ale plăgii chirurgicale.

1. Băieți de fir de sutura recomandat în CM

A. Neresorbabil :
Pentru suturi ale pielii sau mucoaselor care trebuie îndepărtate și pentru fixarea drenurilor pe piele.

- Naturale: Mătase de numerație variabilă.
  Alegerea grosimii firului de mătase va depinde de zona anatomică care urmează să fie suturată și de tensiunea la care va fi supusă. Se va alege cea mai mică grosime posibilă, căutând un echilibru între rezistență și aspectul estetic. Următoarea sugestie poate servi drept ghid:
  - În sutura de piele scalp: Mătase 2/0 și 3/0.
  - În gât și față: Mătase 4/0 la 6/0.
  - În piept, abdomen, spate și membre: Mătase 3/0 și 4/0

- Sintetice:
  - Poliamidă: Ethylon® și Nailon®
  - Polipropilenă: Prolene®

  EL recomandă o calibru pentru suturi în gât și față de 4/0 la 6/0, și pentru torace, abdomen, spate și membre 3/0 și 4/0.

B. Resorbabil:
Pentru suturi adânc, mucoase și țesut celular subcutanat.

- Sintetice
  - Poliflactină 910: Vicryl®
  - Acid poliglicolic: Dexon® II

  El calibru recomandat este 3/0 și 4/0.

2. Băieți de suturi

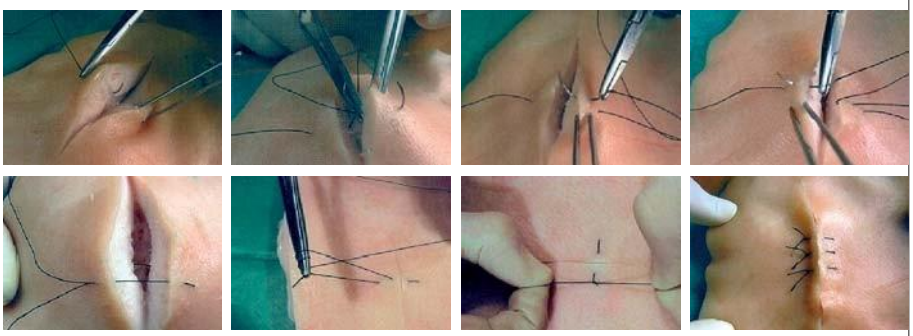
Cea mai frecvent utilizată sutură este sutura întreruptă, în care fiecare cusătură se realizează independent de următoarea, distribuindu-se uniform de-a lungul plăgii chirurgicale. Acest tip de sutură este recomandat datorită caracteristicilor sale:

- Mai departe ușura pentru distribui cel/cea/cei/cele încordare.
- Favorizează el drenaj de cel/cea/cei/cele răni.
- Mai departe ușura pentru retrage cel/cea/cei/cele puncte.

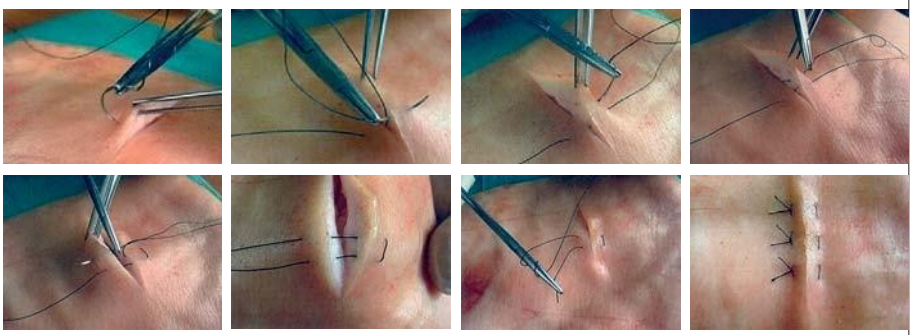
Cel/Cea/Cei/Cele băieţi de loc mai departe recomandat în chirurgie minor sunt:

- Loc simplu.
- Loc simplu cu el nod îngropat. EL performează cu fir resorbabil.
- Punctul de producător de saltele vertical.
- Punctul de producător de saltele orizontală.

Idee simplă



Loc producător de saltele vertical



Loc producător de saltele orizontală

7. Băieţi obişnuit de suturi

2. PROCEDURI CHIRURGICAL NOȚIUNI DE BAZĂ

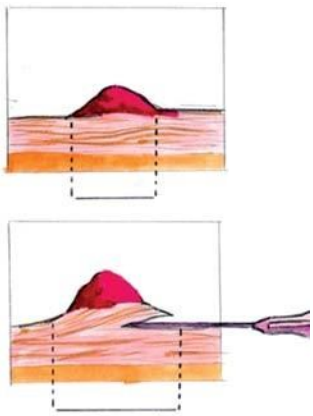
A. Excizie De Leziuni Superficial

1. Clivaj cilindric (Punch)

Instrucțiuni
Tehnică că, de jumătate de o lovitură (instrument că constă de Mânerul și un capăt circular de tăiere (cu diametrul de 2 până la 8 mm) permit obținerea unei probe de piele care pătrunde adânc în hipoderm.

Tehnică
După cel/cea/cei/cele dezinfectare și cel/cea/cei/cele anestezie de cel/cea/cei/cele zonă până cel/cea/cei/cele dermă adânc, el lovitură se aplică de formă perpendicular cu mișcări rotativ până ajunge el țesut subcutanat . După cel/cea/cei/cele hemostază EL sutura și EL trimite cel/cea/cei/cele parte la anatomie patologic.

2. Tehnică de divizare tangențială



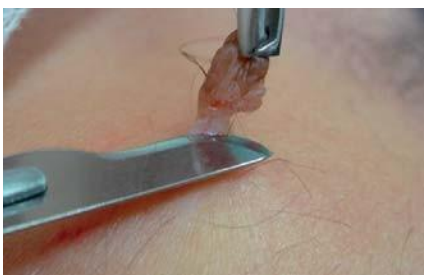
8. Sistem de clivaj tangențial

Instrucțiuni
Aceasta este o tehnică rapidă și simplă, indicată pentru leziuni mici, ridicate sau exocordoane, cum ar fi: keratoze seboreice, excrescențe cutanate, molluscum contagiosum și negi filiformi.

Tehnică

1. Stabiliza cel/cea/cei/cele blană cu cel/cea/cei/cele degete index și degetul mare de mâna nedominanta și într-o direcție perpendiculară pe liniile de tensiune ale pielii.

2. Faceți o incizie perpendiculară pe baza leziunii și paralelă cu pielea (ras), îndepărtând doar straturile superficiale ale pielii.



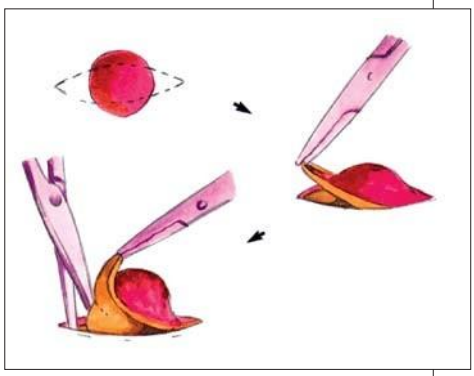
Diviziunile 9a și b tangențial de o etichetă de piele

3. Tehnică de clivaj fusiform

Instrucţiuni

Cel/Cea/Cei/Cele clivaj fusiform este cel/cea/cei/cele tehnică mai departe folosit şi potrivit pentru cel/cea/cei/cele Îndepărtarea leziunilor dermatologice superficiale, cum ar fi nevi, dermatofibroame, fibroame moi şi chisturi.

Tehnică



10. Tehnică de clivaj fusiform

1. Proiectarea exciziei: Se trasează o elipsă cutanată care îndeplineşte următoarele caracteristici: Axa majoră a elipsei trebuie să măsoare de 3 ori diametrul transversal. Unghiul capetelor sale nu trebuie să depăşească 30º pentru a evita apariţia de „urechi de câine" în timpul suturii. Trebuie menţinută o marjă de 2 mm între leziune şi marginea pielii a inciziei. Axa majoră a suturii trebuie să urmeze liniile de tensiune ale pielii.

2. Incizie cutanat superficial: EL performează cu cel/cea/cei/cele sfat al/a/ale scalpel, încordare cel/cea/cei/cele blană, la acesta lung de toate el ax că El pleacă la elimina şi afectând la toate cel/cea/cei/cele adâncime pentru evita graniţe neregulat. Cel/Cea/Cei/Cele incizie EL face dăruire o instanţă curat, Nu tăiere, prindere mango-ul al/a/ale scalpel ca o creion şi performanţă tracţiune cu cel/cea/cei/cele degete de mâna non-dominanta, urmând linia pictată a desenului.

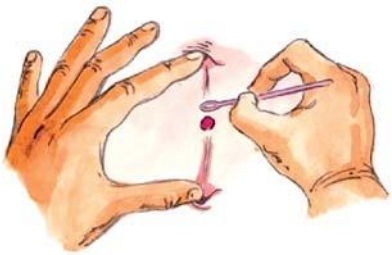
3. Excizia en bloc: Se face o incizie profundă în formă de pană cu lama bisturiului până la atingerea hipodermului, iar ţesutul este retras cu o pensetă anti-ţânţari sau o pensetă dinţată. Odată ce disecţia este completă, leziunea este îndepărtată en bloc.

11. Tehnică clivaj nevus fusiform

12. Tehnică clivaj chist fusiform epidermic.

4. Tehnică de chiuretaj

Instrucţiuni
Enucleaţia negilor, moluscului contagios, miliilor, keratozei seboreice, granulomului de corp străin, etc.



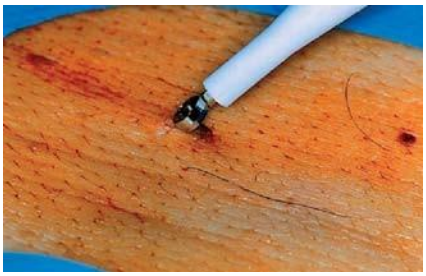
13. Tehnica de chiuretaj

Tehnică

1. Întindeţi pielea şi aplicaţi marginea tăietoare a chiuretei pe bază. de cel/cea/cei/cele vătămare, performanţă o mişcare de pârghie care eliberează leziunea.

2. Da EL performează răzuire, EL va lua cel/cea/cei/cele chiuretă ca o creion şi EL va efectua mişcări tangenţial fermă, rapid şi în jos.

14. Chiurete



15. Tehnici de îndepărtare prin chiuretaj

B. Îndepărtare De Leziuni Subcutanat

Instrucţiuni
Îndepărtarea lipoamelor şi a chisturilor epidermice (chisturi sebacee, chisturi trichilemmale, milia şi chisturi dermoide).

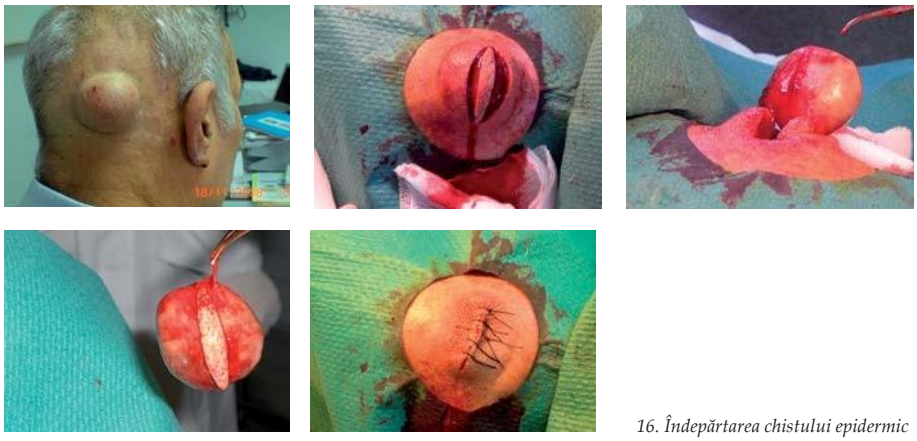
tehnica standard de excizie obişnuită

1. Infiltrat anestezie local de formă perifocal fără străpungere el chist.

2. Incizie superficial: EL va continua el ax cutanat, fără străpungere cel/cea/cei/cele capsulă al/a/ale chist.

3. Excizie-disecţie de cel/cea/cei/cele capsulă: Cu o clemă de disecţie EL ia el margine de cel/cea/cei/cele blană că S.U.A ajuta la diseca, decolare cel/cea/cei/cele capsulă progresiv-

Folosește cu grijă marginea curbată a foarfecelor. Procedează cu precauție. Disecția și îndepărtarea aderențelor, având grijă să se îndepărteze întregul chist cu capsula sa.



16. Îndepărtarea chistului epidermic

C. Incizie și drenaj de abcese cutanat

Introducere

Cel/Cea/Cei/Cele abcese cutanat sunt acumulări de material purulent că Pot apărea în cavitățile pielii sau în cavități produse de distrugere infecțios de cel/cea/cei/cele țesuturi (abces perineal, panaris, fierbe…). El Tratamentul constă în incizie și drenaj.

Tehnica chirurgicală

1. Locație al/a/ale abces de fluctuație.
2. Se infiltrează cu anestezic local de-a lungul liniei inciziei și la 1 cm în afara marginii periferice.
3. Faceți o incizie largă folosind un bisturiu nr. 11 în zona cu cea mai mare fluctuație de-a lungul liniilor de tensiune.
4. Debridare el în interiorul abcesului cu degetul, o clemă Kocher sau foarfecele.
5. Presa toate cel/cea/cei/cele periferie pentru ușura el drenaj și explora cel/cea/cei/cele cavitate.
6. Curățenie și dezinfectare al/a/ale spațiu cu ser fiziologic fie apă oxigenat până când lichidul se scurge cât mai curat posibil.
7. Spălat Sfârșit cu povidonă iodat.

8. Loc drenaj:

- În mic abcese: bandă de şifon de 1-2 cm de larg impregnat cu iodură de povidonă.
- În abcese majore: tub Penrose, acoperi, deget de mănuşă.

9. Aplică pansament voluminos cu ridicat abilitate de absorbţie.

D. Chirurgie Unghie

1. Drenaj de hematom subunghial

Sunt mai frecvente la nivelul degetelor, ca urmare a traumatismelor. durere directă. Tensiunea produsă de acumularea de sânge între placă şi pat este responsabilă pentru durerea intensă, care se va reduce semnificativ după evacuarea acesteia.

Traumatismul trebuie luat în considerare în cazul în care este necesară o evaluare radiologică pentru a exclude posibile fracturi la nivelul falangelor.

Tehnica de drenare a conţinutului sanguinolent nu necesită anestezie şi se va efectua după cum urmează:

1. Curăţare şi asepsie de cel/cea/cei/cele zonă cu iodură de povidonă.

2. Faceţi două găuri în placa unghială folosind un ac teşit de 0,9 x 25, rotindu-l încet până ajungeţi la hematom. Alternativ, puteţi folosi o agrafă de hârtie din metal fierbinte (încălzită cu o brichetă şi ţinută cu o pensetă Kocher) aplicată direct pe unghie. Agrafa va dizolva treptat placa unghială până ajungeţi la hematom.

3. O timp a drenat hematom EL va acoperi el deget cu o pansament steril.

2. Paronichia

EL tratează de o infecţie bacteriene de Intrare cuticulară, adesea secundară manichiurilor agresive şi onicofagiei.

Prin aplicarea de căldură umedă, se poate promova formarea spontană a abceselor şi drenajul, producând o ameliorare imediată a disconfortului.

Numai dacă durerea sau colecţia purulentă este excesivă se face o mică incizie de drenaj cu un bisturiu nr. 11, paralelă cu marginea unghiei, după anestezie digitală.

17. Paronichia

3. Clătită

Cel/Cea/Cei/Cele infecţie situat în el pulpă al/a/ale deget dă loc la o durere intens de către acumulare de puroi în o spaţiu închis. În plus, Da EL frunze evolua poate da loc la complicaţii potenţial (limfangită) sau osteomielită), de care EL face necesar el drenaj chirurgical devreme, separat de o tratament antibiotic sistemic.

Incizia şi drenajul nu trebuie efectuate pe suprafaţa palmară a pulpei, ci pe partea laterală a acesteia, în zona de fluctuaţie maximă. Ulterior, se lasă o drenaj de şifon pentru garanţie cel/cea/cei/cele evacuare complet de cel/cea/cei/cele cavitate.

4. Smulgere unghie

Separarea Îndepărtarea completă a plăcii unghiale din patul său va fi indicată în onicomicoza extinsă fără răspuns la terapia antifungică, în deformările excesive ale unghiilor (onicogrifoză) şi în avulsiile traumatice incomplete.

Tehnică

1. După blocarea anestezică a degetului, se va plasa un garou la baza acestuia, folosind o bandă elastică (compresor) ce va permite o procedură fără sânge.

2. Cel/Cea/Cei/Cele o EL decolează al/a/ale gunoi introducerea o ţânţar închis între ambele şi deschizându-şi ramificaţiile în interior.

3. Apoi se fixează cu o clemă groasă (Kocher) pe una dintre laturile sale şi Se elimină prin tragerea spre partea contralaterală.

4. Patul unghial care sângerează este astupat cu un pansament steril pentru a preveni aderenţa acestuia la patul plăgii şi închis cu un bandaj compresiv, recomandând ridicarea membrului în primele ore după aceea. intervenţiei pentru a evita sângerarea excesivă.

5. Onicocriptoză

Este definită ca creşterea sau încorporarea unghiei în epiteliul înconjurător. Este cunoscută şi sub denumirea de „unghie încarnată” sau „unghie încarnată”. Locaţia mai departe frecvent de obicei fi el primul deget de cel/cea/cei/cele picioare. Cu Zona prezintă adesea o infecţie activă, aşa că se recomandă tratamentul cu antibiotice orale şi antiseptice topice înainte de procedură.

Tehnică

1. Blocadă anestezic al/a/ale deget la interveni.

2. Înainte de procedură, unghia va fi tăiată la acelaşi nivel cu hiponihiul. Dacă unghia este groasă, se recomandă frezarea întregii plăci unghiale pentru a facilita incizia.

3. EL va continua la cel/cea/cei/cele exsanguinare al/a/ale deget şi cel/cea/cei/cele aplicaţie de o garou Se aplică presiune hemostatică pentru a minimiza sângerarea. Acest lucru se realizează prin ridicarea piciorului pacientului şi aplicarea presiunii circumferenţiale cu un compresor, care este apoi fixat la baza degetului de la picior cu o clemă Kocher . fie suport pentru ac. Acest ischemie EL poate păstra aproximativ aproximativ 15 minute.

4. Începem cel/cea/cei/cele intervenţie procedură la cel/cea/cei/cele smulgere parţial de cel/cea/cei/cele o. Poate ajută-ne el bifă cu o marker dermografic cel/cea/cei/cele porţiune parte a elimina, că necesitate fi paralel către axă longitudinal de cel/cea/cei/cele placă unghie. Începe el instanţă de cel/cea/cei/cele o din el margine distal către proximal cu el scalpel cu instanţă căutând spre el dragă/dragă. Continuăm mergând înainte şi am petrecut de de mai jos cel/cea/cei/cele cuticulă până ajunge la cel/cea/cei/cele matrice. Vom observa o scădere de cel/cea/cei/cele rezistenţă către avans al/a/ale scalpel, a continuat de o rezistenţă Sfârşit brusc la atingerea cu el condil dorsal proximal de cel/cea/cei/cele primul angă. În continuare, vom continua la scoate cel/cea/cei/cele frunze al/a/ale gunoi unghie şi cel/cea/cei/cele ţesuturi adiacent. În final, tragem de partea secţionată a cuiului cu ajuta de o kocher fie titular. EL sfătuieşte executa acest operaţiune prin o întoarcere blând în adresa al/a/ale margine intervenţie la nivelul unghiilor .

5. După ce spicula a fost îndepărtată, se efectuează chiuretajul. de cel/cea/cei/cele matrice, gunoi şi canale paturi unghiale. Pentru asiguraţi-vă că Odată ce nu mai rămâne matrice, trebuie să răzuim periostul falangei. Apoi, resturile de ţesut debridat sunt curăţate temeinic cu soluţie salină, zona este dezinfectată şi, în final, garoul este îndepărtat, verificând dacă circulaţia a revenit. la cel/cea/cei/cele normal (el deget se recuperează cel/cea/cei/cele temperatură şi culori normale).

6. Adesea putem găsi ţesut de granulaţie exuberant pe pliul unghial afectat. Vom proceda apoi la îndepărtarea acestuia. îndepărtare performanţă o incizie "în cameră de portocale".

7. Cel/Cea/Cei/Cele uniune de cel/cea/cei/cele o cu el chiflă unghie EL poate do pur şi simplu cu adezivi pentru piele. În cazul în care s-a efectuat excizia al/a/ale ţesut de granulare poate fi precis cel/cea/cei/cele Suturaţi cu mătase pentru a apropia pernuţa unghiei de unghie.

18. Tehnica chirurgicală onicocriptoză.

E. Extracţie De Granulom De Corp Ciudat

Definiţie
Reacţie granulomatoasă în ţesutul subcutanat din jurul unui corp străin care cu el trecut al/a/ale timp, poate încapsula fie chiar a deveni infectat şi produce un abces.

Tehnică

1. Prezentare de cel/cea/cei/cele accidentare: granulom ridicat despre cel/cea/cei/cele epidermă.
2. Infiltrare de cel/cea/cei/cele anestezie de formă perifocală.
3. EL performează o incizie larg că acoperi toate cel/cea/cei/cele zonă ridicat.
4. Cu pensetă de disecţie fie hemostatic EL extracte el corp ciudat.
5. Cu linguriţă EL face chiuretaj de cel/cea/cei/cele baza al/a/ale granulom pentru lui curăţenie şi astfel să prevină orice urme de material contaminat.
6. Spălare cu ser la jet.
7. Sutură cu copci simplu, lăsând suficientă distanţă între ei pentru pentru a drena o posibilă infecţie dacă aceasta apare.

F. Reconstrucţie Dintre Lob De Cel/Cea/Cei/Cele Ureche

Introducere
El rupere al/a/ale lob de cel/cea/cei/cele ureche de obicei să se întâmple de o traumă acute sau cronice legate de utilizarea cerceilor. De asemenea, au fost observaţi anumiţi factori predispozanţi, cum ar fi: infecţii repetate, reacţie alergică cauzată de materialul cerceilor, un piercing jos şi grosimea lobilor urechii (grosimile mai mici de 4 mm prezintă un risc mai mare). probabilitate de rupere), şi cel/cea/cei/cele vârstă avansat al/a/ale pacient.

Tipuri de lacrimi
EL ei pot clasifica în două grupuri:

- Rupere incomplet
- Rupere complet.

În orice caz cel/cea/cei/cele indicaţie de chirurgie corector este estetică şi trebuie să individualiza .

Procedura chirurgicală

1. Loc către pacient în poziție culcat pe spate culcat pe spate, cu cel/cea/cei/cele cap înclinat și ștecher acoperiți canalul auditiv cu tifon pentru a preveni pătrunderea sângelui.

2. Infiltrarea anestezicului pe ambele părți ale rupturii. O altă opțiune este infiltrarea întregii auricule folosind un bloc auricular.

3. Incizie. Variază conform el tip:

   a) Ruptură incompletă. Marginile sunt împrospătate, median- Excizia simplă se efectuează folosind forcepsul de disecție și un bisturiu. Când ruptura este extinsă, prezentând o mică punte de țesut restant în partea inferioară a lobului, aceasta este secționată și corectată ca în cazul rupturilor complete.

   b) Ruptură completă. Se efectuează o excizie în formă de V inversat. Pentru reîmprospătarea marginilor, cu un bisturiu sau o foarfecă dreaptă, detașând ulterior marginile de piele 1 sau 2 mm pe ambele părți pentru a preveni „crestătura”. la margine mai mică de lob.

4. Pentru termina EL sutura el lob de lui faţă fost şi mai târziu în direcții perpendiculare.

Această tehnică nu păstrează orificiul cercelului, care va trebui perforat din nou .

Considerații

- O lung sutura longitudinal poate contracta în cel/cea/cei/cele cicatrizare și pentru a provoca o crestătură pe marginea lobului.

- Reperforarea nu este posibilă decât la șase săptămâni după corecția chirurgicală .

- Pacientul trebuie să evite cerceii grei timp de șase săptămâni după reparare.

19. Tehnică chirurgical reconstructor al/a/ale lob de cel/cea/cei/cele ureche.

G. Chirurgie Distructiv De Leziuni Superficial

1. Criochirurgie

Criochirurgia (distrugerea leziunilor cutanate prin congelare rapidă) este un tratament eficient şi simplu, care nu necesită nici anestezie, nici suturi. Este indicată pentru leziuni superficiale benigne, cum ar fi negi, molluscum contagiosum, excrescenţe cutanate mici şi keratoze seboreice. Deoarece nu se prelevează nicio probă pentru examinare histologică, aceasta trebuie evitată ori de câte ori există îndoieli cu privire la malignitatea leziunii care urmează să fie tratată.

Cel mai frecvent utilizat agent crioterapeutic este azotul lichid, care atinge o temperatură de -195ºC (temperaturi mai jos Temperaturile de -20°C sunt considerate letale pentru piele). Alţi agenţi crioterapeutici constau din amestecuri volatile (de exemplu, dimetil eter-propan: Histofreezer®) care, după aplicare legume şi fructe, prin evaporare, o "scăzut congelare" suficientă pentru distrugerea anumitor leziuni.

Cel/Cea/Cei/Cele tehnică este foarte simplu şi constă în robinet cel/cea/cei/cele accidentare cu o tampon de bumbac impregnat în azot lichid (el dimetil eter-propan EL (Furnizat cu aplicatoare de unică folosinţă, care se termină cu un beţişor din spumă sau bumbac). Beţişoarele trebuie aplicate vertical pe leziune pentru a concentra cea mai scăzută temperatură posibilă pe vârful lor, până când se obţine un bloc de îngheţ al pielii care acoperă leziunea şi 1-2 mm de piele sănătoasă din jur . Zona îngheţată va deveni albă şi ar trebui să rămână aşa timp de 30-90 de secunde. conform cel/cea/cei/cele accidentare fi mai departe fie Mai puţin superficial. Cât costă vârstnici fi el timp şi cel/cea/cei/cele presiune exercitat cu cel/cea/cei/cele tampon mai departe adânc va fi cel/cea/cei/cele congelare. După decongelare apare o băşică dermo-epidermal şi ulterior se întâmplă o mic crustă scăzut cel/cea/cei/cele că EL reepiteliază cel/cea/cei/cele zonă în 10-14 zile fără

să lase o cicatrice vizibilă. După această perioadă, se poate lua în considerare o nouă aplicare dacă răspunsul a fost parţial.

În timpul aplicării, pacientul resimte doar o uşoară senzaţie de arsură care, de obicei, se intensifică în timpul decongelarii.

2. *Electrochirurgie*

Bisturiele electrice transformă energia electrică din reţea în căldură, prin urmare cel/cea/cei/cele rezistenţă de cel/cea/cei/cele ţesuturi către trecut de cel/cea/cei/cele actual. Conform cel/cea/cei/cele lungime de Cu forma de undă a curentului se realizează diferite aplicaţii:

- Electrodesicare: Distrugere de răni superficial.
- Electrocoagulare: Hemostază de ţesuturi sângerare.
- Electrosecţie: Secţionarea leziunilor ridicate sau pedunculate de pe suprafaţa pielii.

Pentru chirurgia pielii se utilizează dispozitive monopolare care au un electrod terapeutic (mâner cu capete interschimbabile) şi un electrod de dispersie (placă) care, plasat într-o anumită zonă îndepărtată a corpului al/a/ale pacient, aproape el circuit. Toate cel/cea/cei/cele modele a avea o selector de frecvenţă că modifică cel/cea/cei/cele atmosferă pentru legume şi fructe cel/cea/cei/cele diferit modalităţi de terapie şi un selector de intensitate a curentului pentru a regla efectul produs.

Instrucţiuni

Secţionarea, excizia, distrugerea celulară sau tăierea leziunilor cutanate benigne (fibroame moi, angioame tip cireş, angioame tip păianjen, negi, granulom piogen, etc.) şi hemostaza punctelor de sângerare (electrocoagulare).

Contraindicaţii

- Nu foloseşte-l ca metodă de tratament în răni cu suspiciune de malignitate fie în răni pigmentat fără o diagnostic anterior de certitudine.
- Nu EL trebuie să utilizare Da el pacient este purtător de stimulator cardiac extern la cerere fie în prezenţă de modificări al/a/ale ritm cardiac de orice tip.

Acestea nu sunt contraindicaţii

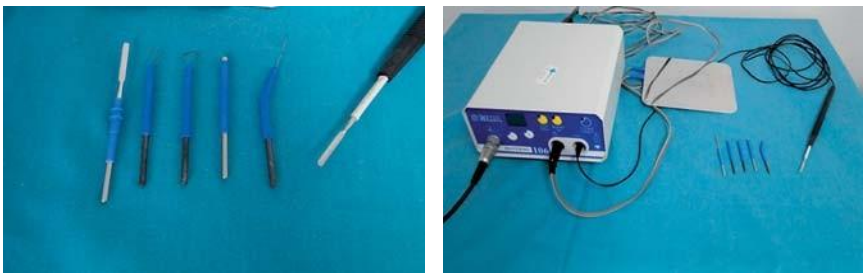
- Proteze dentare Nu amovibil metalic (poduri fix, implanturi…).
- Proteză metalic (unghii, şuruburi).
- Dispozitive intrauterină.

Precauții

- Retrage toate obiect metal în contact cu cel/cea/cei/cele blană.
- Nu utilizare antiseptice combustibili.
- Utilizare mănuşi intact.
- Utilizarea măştilor pentru a evita inhalarea vaporilor potențial infecțioşi .

Procedură

- Electrodesicare: Acest tehnică Nu trebuie să fi folosit Da Sunt îndoieli despre cel/cea/cei/cele natura leziunii care trebuie distrusă, deoarece nu permite obținerea de probe de țesut pentru analiză ulterioară. Aceasta se face cu un electrod mare, în formă de sferă, care este mişcat încet pe suprafața leziunii fără a aplica presiune, producând leziuni tisulare foarte superficiale. Când leziunea face bule sau îşi schimbă culoarea, ţesutul necrotic este îndepărtat prin frecare. cu tifon. Ulterior se aplică pansamente umede până când zona este reepitelizată fără sechele.
- Cel/Cea/Cei/Cele electrosecție EL performează cu electrozi în formă de mâner fie ac cu cel/cea/cei/cele că gâtul rănii este tăiat.
- Electrocoagularea vaselor hemoragice este cea mai convenabilă şi eficientă tehnică. de hemostază chirurgical. Cel/Cea/Cei/Cele formă corecta de arestare el sângerare este coagulare aluzie al/a/ale loc sângerare aplicarea cel/cea/cei/cele actual la printr-un vârf fin al unei pense Adson sau al unei pense pentru țânțari, distrugând foarte selectiv patul chirurgical pentru a nu interfera cu vindecarea normală.



20. Echipament de electrochirurgie cu mai multe băieți de capete de imprimare

3. URMARE ŞI TRATAMENTE POST-CHIRURGICAL

Procesul nu se încheie şi, prin urmare, pacientul nu este externat până când procesul de vindecare nu este complet. de cel/cea/cei/cele răni chirurgical EL Ha produs şi EL ei au rezolvat cel/cea/cei/cele posibile complicaţii.

În perioada postoperatorie, se vor aborda următoarele nevoi :

A. Preoţi Postoperator De Cel/Cea/Cei/Cele Răni Chirurgical

- După ce plaga a fost suturată, orice urmă de sânge rămasă pe suprafaţa suturată a plăgii trebuie îndepărtată şi curăţată cu soluţie salină fiziologică, iar sutura trebuie apoi impregnată cu iodură de povidonă.

- Este recomandabil să izolaţi sutura de exterior în primele 24-48 de ore prin aplicarea unui pansament steril, în special pentru rănile care sunt loc în zone de frecare fie cu posibilitate de poluare. Cel/Cea/Cei/Cele rană EL va menţine curat şi uscat, punte cu îmbrăcare. Da el pansament EL urmărire de oameni de sânge, necesitate înlocui de alte curat previzualizare curăţenie de cel/cea/cei/cele rană cu povidonă-iodură.

- În uneori, este necesar executa o bandaj compresiv când există risc de hemoragie Eu imobiliza cu o atelă Da cel/cea/cei/cele răni EL găseşte situat într-o zonă cu tracţiune ridicată, aşa cum se întâmplă la nivelul membrelor.

- După primele 24-48 de ore de sutură, trebuie efectuată o primă verificare a zonei:

  EL se va retrage el bandaj şi EL va valora el stat de cel/cea/cei/cele răni şi Da cel/cea/cei/cele hemostaza a fost corecta. Este normal că cel/cea/cei/cele graniţe sunt uşor înroşit, acesta că Nu indică neapărat o infecţie, ci o inflamaţie, un proces logic asociat cu cicatrici postoperatorii.

  Da cel/cea/cei/cele inflamaţie este extins şi huse o extensie între 0,5 şi 1 cm În jurul marginii suturii, trebuie luată în considerare posibilitatea ca plaga chirurgicală să se fi infectat.

  Apoi, vom apăsa uşor pe conturul suturii pentru a evalua dacă aceasta curge în vreun punct. Dacă materialul drenat este purulent, acesta va fi eliminat. din punctul infectat pentru a permite închiderea acestuia prin intenţie secundară. Când lichidul care apare este serosangvin, vom avea de-a face cu o serom sau hematom şi va fi necesară drenarea acestuia şi aplicarea unui bandaj compresiv.

După cel/cea/cei/cele evaluare EL va decide el întreţinere fie Nu al/a/ale pansament, conform cel/cea/cei/cele zonă şi caracteristici al/a/ale pacient, a fi capabil din acest moment umed cel/cea/cei/cele rana în timpul igienei personale şi apoi uscarea acesteia cu grijă.

- Cel/Cea/Cei/Cele periodicitate de cel/cea/cei/cele preoţi mai târziu de cel/cea/cei/cele răni Va depinde din :

  - El grad de poluare de cel/cea/cei/cele răni (curat, murdar fie infectat)
  - Cel/Cea/Cei/Cele locaţie anatomic.
  - El tip de cicatrizare (primul, doilea fie treilea intenţie)
  - Cel/Cea/Cei/Cele utilizare fie Nu de drenaj.
  - Cel/Cea/Cei/Cele evoluţie de cel/cea/cei/cele răni.

B. Analgezie

În general, durerea este uşoară şi poate fi controlată cu paracetamol în dozele recomandate. obişnuit; Da acest Nu ar trebui să se întâmple, ei pot asociat alţii analgezice. În În cazurile de durere severă, rana va fi evaluată pentru a exclude prezenţa complicaţiilor (hematom, infecţie etc.).

C. Profilaxie Antibiotic

Cel/Cea/Cei/Cele administrare de antibiotice de prin oral are rar valoare la cel/cea/cei/cele oră pentru a preveni infectarea plăgii. Se vor utiliza următoarele:

- Când există ridicat risc de infecţie postoperator fie performanţă peste zonele contaminate.

- Întotdeauna, dacă există criterii pentru efectuarea endoprofilaxiei cardită bacteriană.

EL va alege el antibiotic cu el spectru mai departe potrivit conform cel/cea/cei/cele posibil germeni agenţi patogeni, a face cunoştinţă că el Stafilococ auriu este el mai departe frecvent izolat în cel/cea/cei/cele infecţii cutanat. Pentru cel/cea/cei/cele microorganisme Cloxacilina rezistentă la penicilină sau amoxicilină-acidul clavulanic vor fi medicamentele de elecţie.

Culturile şi antibioticele topice nu sunt de obicei necesare.

D. Canalizări

Drenurile, care se vor plasa întotdeauna după eliberarea unui abces şi, de asemenea, în plăgile cu risc crescut de infecţie sau sângerare, se vor menţine la locul lor atât timp cât persistă exudaţia, cu schimbări periodice după cum este necesar.

E. Retragere sutură

Momentul pentru îndepărtarea suturilor va depinde de mai mulţi factori, cum ar fi cel/cea/cei/cele caracteristici de cel/cea/cei/cele zonă anatomic, el

grosime de cel/cea/cei/cele epidermă, el tu-

po de închidere şi cel/cea/cei/cele încordare de cel/cea/cei/cele răni. Asemenea EL va avea în cont că la vârstnici timp de persistenţă de cel/cea/cei/cele sutura vârstnici risc de reacţie inflamator acest, cu mai rău rezultat estetic. De alte lateral, cel/cea/cei/cele retragere devreme poate favorizează redeschiderea sau dehiscenţa plăgii.

În fiecare caz, timpii de îndepărtare a suturilor vor fi individualizaţi, să aibă loc, Da Sunt îndoieli, de formă alterna. Cel/Cea/Cei/Cele timp mass-media Recomandate, în funcţie de regiunea anatomică, pot fi:

Faţă .....4-5 zile
Piele scalp ..... 7 zile
Faţă fost al/a/ale portbagaj .....8-10 zile
Membri clasele 10-12 superioare..... zile
Spate şi membre mai mic .....10-14 zile

Întotdeauna EL va lua la pelerină previzualizare curăţenie de cel/cea/cei/cele zonă cu povidonă Iodat şi folosind tehnica sterilă. Se va aplica tracţiune la capătul fiecărei cusături, tăind între el nod şi cel/cea/cei/cele blană de mod că, către arunca, se întâmplă cel/cea/cei/cele minim cantitate de fir la prin de cel/cea/cei/cele răni. Este important arunca al/a/ale fir în cel/cea/cei/cele adresa că Închide rana, pentru că în acest moment Există încă riscul de că asta deschide.

În unele cazuri, plasarea ulterioară a suturilor adezive poate fi utilă pentru a reduce tensiunea de pe marginile plăgii atât timp cât se consideră necesar.

F. Complicaţii Postoperator

1. Hemoragie

De obicei, se datorează traumatismului plăgii chirurgicale, hemostazei intraoperatorii inadecvate, administrării de medicamente cu acţiune asupra sistemului de coagulare sau discraziilor sanguine.

Ei pot exista mai multe băieţi de sângerare: capilar (în foaie), venos (flux continuu) sau arterial (roşu pulsatil, mai intens şi abundent).

El tratament Acesta va consta din:

- Aplicaţi compresie digitală (sau compresie cu un tampon de tifon) pe rană timp de 10-15 minute. minute, aplicând ulterior un bandaj compresiv pe aceasta.

- Aplicaţi gheaţă rece (compresa cu gheaţă) pe zona afectată în următoarele ore, în perioade repetate de 10-15 minute.

Hemoragia poate fi prevenită prin efectuarea unei tehnici hemostatice adecvate în timpul procedurii chirurgicale.

2. Serom

Constă în în cel/cea/cei/cele aspect de o colectare lichid scăzut cel/cea/cei/cele sutura. Se întâmplă Când au rămas cavităţi sau spaţii moarte, sutura trebuie îndepărtată şi se aplică compresie a pielii pentru a drena conţinutul.

3. *Hematom*

Vânătăile mici se reabsorb de obicei spontan. Cele mai mari dimensiune EL ei/ele vor evacua la prin de cel/cea/cei/cele incizie chirurgical, fie retragere unele dintre suturi, aplicând presiune cu o dischetă demachiantă şi plasând un dren, dacă se consideră necesar.

Lui aspect poate stare o vârstnici risc de alte complicaţii, cum ar fi dehiscenţa, infecţia sau necroza.

Pentru a preveni formarea acesteia, se va efectua o hemostază intraoperatorie adecvată şi suturarea în straturi fără a lăsa spaţii între ţesuturile afectate, plasând ulterior un bandaj compresiv.

4. Infecţie

Poate apărea în până la 1% din cazurile de intervenţii chirurgicale minore curate, fiind frecvent legată de eşecuri ale tehnicii sterile. Poate fi, de asemenea, etapa finală. de alte complicaţii, ca el hematom, cel/cea/cei/cele dehiscenţă şi cel/cea/cei/cele Necroză. Semnele şi simptomele apar de obicei între a patra şi a opta zi postoperatorie, cele mai frecvente fiind: durere, umflare şi roşeaţă a cel/cea/cei/cele graniţe de cel/cea/cei/cele răni şi, în uneori, supuraţie de material purulent.

Rareori Sunt simptome general ca febră Eu tremurând.

El tratament va consta în:

- Îndepărtarea suturilor necesare, curăţarea şi dezinfecţia zilnică şi permiterea închiderii plăgii prin intenţie secundară; Se va instala drenaj, dacă este necesar.

- Iniţiaţi terapia antibiotică orală empiric cu antibioticele descrise mai sus.

5. Dehiscenţă de sutura

Este separarea marginilor rănii înainte ca aceasta să se vindece complet .

Există factori predispozanţi legaţi de pacient, cum ar fi vârsta înaintată, bolile cronice, consumul de medicamente sau malnutriţia. Secundar intervenţiei chirurgicale: tensiune excesivă pe marginile plăgii, utilizarea de material de sutura nepotrivit fie retragere devreme al/a/ale aceleaşi.

Poate fi cel/cea/cei/cele fază Sfârşit de alte complicaţii, ca el hematom fie cel/cea/cei/cele infecţie .

O timp produs cel/cea/cei/cele dehiscenţă, cel/cea/cei/cele cicatrizare va avea loc de a doua intenţie, cu rezultatul estetic slab în consecinţă.

Pentru a preveni acest complicaţie EL va performa o tehnică chirurgical corect, folosind material de sutura potrivit şi închidere de planuri. EL voi încerca scădere cel/cea/cei/cele încordare în cel/cea/cei/cele sutura prin disecţie subcutanat de cel/cea/cei/cele margini.

6. Granulom de sutura

EL produce în o zonă unde există o loc îngropat fie investit, de reacţie de tip corp ciudat către material de sutura, apariţia o nodulaţie dureros şi greu.

Ca măsură de prevenţie EL va folosi material resorbabil al/a/ale calibru mai fin posibil, performanţă puţini noduri, adânc şi plecând pelerine foarte pantaloni scurţi.

7. Dermatită de contact

Cel/Cea/Cei/Cele aspect de răni eczematos cu prurit asociat în cel/cea/cei/cele zonă Zona din jurul plăgii chirurgicale este de obicei cauzată de hipersensibilitate la antiseptice, pansamente, bandaje adezive, antibiotice topice sau altele.

Dacă se detectează agentul cauzal, acesta trebuie îndepărtat şi se va lua în considerare aplicarea de corticosteroizi topici.

8. Eczemă necrotică

Se întâmplă de tulburare de cel/cea/cei/cele circulaţie distal în cel/cea/cei/cele margini de cel/cea/cei/cele răni, în general din cauza tensiunii excesive şi ischemiei marginilor provocând hipoxie tisulară. Cel/Cea/Cei/Cele pacienţi fumători a avea vârstnici risc de dezvolta necroză.

El tratament va consta în:

- Debridare larg şi curăţenie al/a/ale ţesut necrotică.
- Antisepsie abundent de rana .
- Antibiotice de formă devreme Da există risc de infecţie.

9. Cicatrice hipertrofic

Este o tulburare de cel/cea/cei/cele cicatrizare normal.

În cel/cea/cei/cele cicatrice hipertrofic EL produce o proeminenţă de acest că respect Limitele sale. Gradul său Cazul extrem este cheloidul, în care ţesutul fibros se extinde dincolo de limitele cicatricei, fiind de natură permanentă.

EL produce de o creştere excesiv al/a/ale ţesut conjunctiv datorat la o lipsă de control reglator al epidermei. Zonele preferate de localizare sunt pieptul, partea superioară a spatelui şi umerii. Există o predispoziţie individual de fiecare persoană şi este foarte dificil de a preveni. Este mai departe frecvent că apărea în tineri şi oameni de rasă negru. Cel/Cea/Cei/Cele pacienţi Pacienţii cu antecedente de boli ar trebui trimişi la chirurgie plastică.

10. Hiperpigmentare de pielea

Această modificare apare de obicei în zonele expuse la soare şi este mai frecventă la persoanele cu pigmentarea pielii închisă la culoare.

Toate cicatricile chirurgicale din zonele expuse la soare trebuie protejate cu produse de protecţie solară timp de cel puţin şase luni după operaţie.

Ocazional, hiperpigmentarea se poate ameliora şi chiar se poate rezolva spontan .

4. PLANURI DE ÎNGRIJIRE STANDARDIZAT

Prin consens în cadrul Grupului de lucru, se convine să se utilizeze metodologia Procesului de Atenţie de Asistenţă medicală că ia în considerare cel/cea/cei/cele Atenţie că împrumuta asistentele medicale ca proces de rezolvare a problemelor.

În vederea orice problemă de sănătate este necesar do o evaluare de nevoile al/a/ale pacient şi în baza la ei formula cel/cea/cei/cele diagnostice de asistenţă medicală aprobată de taxonomia NANDA (North American Nursing Diagnostics) (Asociaţie). Pentru fiecare diagnostic, sunt stabilite rezultate sau obiective NOC (Clasificarea Rezultatelor de Îngrijire Medicală) prioritizate , care trebuie atinse cu anumite intervenţii asistente medicale Placă de reţea (Asistenţă medicală Intervenţii Clasificare) prin diverse activităţi.

Există că a avea în cont că fiecare persoană va prezenta nevoi din evaluarea individualizată se vor obţine diagnostice de asistenţă medicală diferite şi prin urmare diferite.

Aşa cel/cea/cei/cele Planuri pregătit pentru el atent de cel/cea/cei/cele oameni că faţă O intervenţie CM este organizată conform structurii: Diagnosticuri NANDA - Obiective NOC - Intervenţii NIC - Activităţi.

Acest ghid prezintă un Plan general de îngrijire care porneşte de la diagnosticele de asistenţă medicală comune aproape tuturor persoanelor în furnizarea de servicii de chirurgie minoră. :

1. Risc de accidentare perioperator (00087)
2. Anxietate (00146)
3. Deteriorare de cel/cea/cei/cele integritate ţesut (00044)
4. Durere ascuţit (00132)
5. Risc de infecţie (00004)

1. Diagnostic NANDA: Risc de accidentare perioperator (00087)

Definiţie

Risc de vătămare corporală cauzat de condiţiile de mediu prezente în mediul perioperator.

Factori de risc
- Dezorientare.
- Imobilizare.
- Modificări senzorial-perceptiv datorat la cel/cea/cei/cele anestezie.

1.1 NOC: Controla al/a/ale risc (1092)

1.1.1 NIC: Precauții chirurgicale (2920)
- Asigura cel/cea/cei/cele documentare și comunicare de orice alergie.
- Cerere către pacient fie tovarăș că declara el nume al/a/ale pacient.

1.1.2 NIC: Precauții privind sângerarea (4010)
- Instruiţi pacientul și/sau familia despre semnele de sângerare și privind acțiunile adecvate.

1.1.3 Placă de rețea: ID-ul de riscuri (6610)
- Determina el conformitate cu cel/cea/cei/cele tratamente doctori și de îngrijire.
- Determina cel/cea/cei/cele prezenţă și calitate al/a/ale sprijin familiar.

1.1.4 Placă de rețea: Controla de infecții (6540)
- Asigura o tehnică de îngrijire de răni adecvat.
- Gestionează o agent de imunizare dacă este cazul.
- Gestionează terapie antibiotic Da încoace.
- Predă către pacient și la cel/cea/cei/cele familial la evita infecţii.
- Instrui către pacient și la cel/cea/cei/cele familial despre cel/cea/cei/cele semne și simptome de infecţie și când ar trebui să le raporteze profesionistului.

2. Diagnostic NANDA: Anxietate (00146)

Definiţie
Un sentiment vag de nelinişte sau ameninţare, însoţit de un răspuns autonom (a cărui origine este adesea necunoscută individului); un sentiment de nelinişte cauzat de anticiparea pericolului. Este un semnal de avertizare care alertează asupra unui pericol iminent și permite individului să ia măsuri pentru a-l face faţă.

Factori înrudit
- Nevoi Nu mulţumit.
- Criză maturizare sau situaţională.
- Stres.
- Ameninţare de schimba în: el rol, stat sănătate, în jurul...

2.1 NOC: Control de sine de cel/cea/cei/cele anxietate (1402)

2.1.1 NIC: Învățare preoperatorie (5610)

- Pentru a cunoaşte experienţele chirurgicale anterioare ale pacientului şi nivelul său de cunoştinţe legate de chirurgie.
- Da timp către pacient pentru că do întrebări şi discuta lor preocupări .
- Descrie cel/cea/cei/cele rutine preoperator.
- Evalua cel/cea/cei/cele anxietate al/a/ale pacient/ fi dragă înrudit cu cel/cea/cei/cele chirurgie.
- Informa către pacient/ fi dragă de cel/cea/cei/cele durată aşteptat de cel/cea/cei/cele operaţiune .
- Informa către fi dragă despre el loc de aşteptaţi.
- Consolida cel/cea/cei/cele încredere al/a/ale pacient în el personal implicat, Da încoace .

2.1.2 NIC: Reducerea anxietății (5820)

- Administraţi medicamente pentru reducerea anxietăţii, dacă sunt prescrise .
- Încuraja cel/cea/cei/cele manifestare de sentimente, percepţii şi temeri.
- Crea o atmosferă că facilita cel/cea/cei/cele încredere.
- Explica toţi proceduri, inclusiv cel/cea/cei/cele posibilele senzaţii care pot fi resimţite în timpul procedurii.
- Instrui către pacient despre el utilizare de tehnici de relaxare.
- Furnizaţi informaţii obiectiv respect al/a/ale diagnostic, tratează-minciună şi prognostic.
- Încercaţi să înţelegeţi perspectiva pacientului asupra unei situaţii stresante.
- Utilizare o abordare senin că de securitate.

2.1.3 Placă de rețea: Tehnică de relaxare (5880)

- Vorbi cu blândețe.
- Păstraţi contact vizual cu el pacient.
- Reduce fie elimina cel/cea/cei/cele stimuli că crea frică fie anxietate.
- Simţiţi şi vorbi cu el pacient.
- Utilizare cel/cea/cei/cele distragere a atenţiei, Da încoace.

3. Diagnostic NANDA: Deteriorare de cel/cea/cei/cele integritate țesut (00044)

Definiție

Leziuni de cel/cea/cei/cele membrane membrană mucoasă fie corneană, tegumentar fie de cel/cea/cei/cele ţesuturi subcutanate .

Factori înrudit
- Factori extern mecanică.

3.1 NOC: Vindecare de cel/cea/cei/cele răni de primul intenție (1102)

3.1.1 Placă de rețea: Îngrijire al/a/ale loc de incizie (3440)
- Aplică antiseptic.
- Aplică o bandaj potrivit pentru proteja cel/cea/cei/cele incizie.
- Schimba el bandaj la cel/cea/cei/cele intervale potrivit.
- Învățați pacientul și/sau familia cum să îngrijească incizia, inclusiv semnele și simptomele de infecție.
- Ceas el proces de vindecare în el loc de cel/cea/cei/cele incizie.
- Retrage cel/cea/cei/cele suturi când acest indicat.

3.1.2 NIC: Supraveghere a pielii (3590)
- Descoperi cel/cea/cei/cele temperatură de cel/cea/cei/cele blană.
- Observa lui culoare, căldură, impulsuri, textură și Da există inflamație, edem.

4. Diagnostic NANDA: Durere ascuțit (00132)

Definiție

Experiență sensibil emoțional și dezgustător cauzat de o accidentare țesut, real fie potențial descris în astfel de termeni (Internațional Asociere pentru cel/cea/cei/cele Studiul Durere), de început brusc fie lent, de orice intensitate de ușoară la serios, constantă sau recurent cu o Sfârșit devreme fie previzibil și durată minor de șase luni.

Factori înrudit

Agenți dăunător (biologic, substanțe chimice, fizic, psihologic)

4.1 NOC: Controla al/a/ale durere (1605)

4.1.1 NIC: Managementul durerii (1400)
- Încuraja către pacient la utilizare medicament pentru el durere adecvat.
- Asigurați-vă că pacientul primește tratament adecvat pentru gestionarea durerii. orientare.
- Luați în considerare cel/cea/cei/cele influențe cultural despre cel/cea/cei/cele răspuns către durere.
- Verifica cel/cea/cei/cele factori mediu că mai influența în cel/cea/cei/cele răspunsul la durere.
- Determina el impact de cel/cea/cei/cele experiență al/a/ale durere despre cel/cea/cei/cele calitate al vieții (somnul etc.).
- Predă el utilizare de tehnici Nu farmacologic.
- Explora cu el pacient cel/cea/cei/cele factori că ameliorează/agravează el durere.
- Utilizare măsuri de controla al/a/ale durere înainte de că el durere fi severă.

4.1.2 Placă de rețea: Management de cel/cea/cei/cele medicamente (2380)

- Știu Da el pacient acest folosind remedii de casă bazat în cultura lor și cel/cea/cei/cele posibil efecte că mai a avea despre el utilizare de medicamente fără prescripţie medicală şi medicamente eliberate pe bază de reţetă.
- Verifica el conformitate al/a/ale regim de medicament.
- Determinați factorii care pot împiedica pacientul să ia medicamentele conform prescripţiei.
- Învățați pacientul și/sau familia metoda de administrare a medicamentelor, dacă este cazul.
- Explica către pacient Eu la cel/cea/cei/cele familial cel/cea/cei/cele acţiune şi cel/cea/cei/cele efecte efectele secundare așteptate ale medicamentului.
- Observa Da există semne şi simptome de toxicitate de cel/cea/cei/cele medicament.
- Observa Da EL legume şi fructe efecte advers derivate de cel/cea/cei/cele droguri.

5. Diagnostic NANDA: Risc de infecţie (00004)

Definiție

Crește al/a/ale risc de fi invadat de microorganisme agenți patogeni.

Factori de risc

- Distrugere ţesut.
- Alterarea apărării primare (ruptură a pielii, traumatisme tisulare ...)
- Boli cronici.

5.1 NOC: Vindecare de cel/cea/cei/cele răni de primul intenție (1102)

5.2 NOC: Vindecare de cel/cea/cei/cele răni de doilea intenție (1103)

5.2.1 Placă de rețea: Controla de infecții (6540)

- Gestionează terapie de antibiotice, Da încoace.
- Gestionează o agent de imunizare, dacă este cazul.
- Asigura o tehnică de îngrijire de răni adecvat.
- Predă către pacient şi la cel/cea/cei/cele familial la evita infecţii.
- Predă către personal de îngrijire el spălat de mâini adecvat.
- Promova cel/cea/cei/cele admisie de lichide, Da încoace.
- Promova o admisie nutrițional adecvat.
- Instruiți pacientul și familia despre semnele și simptomele infecţiei şi când să le raporteze.
- Spălați-vă pe mâini înainte și după fiecare activitate de îngrijire a pacientului .
- Purta mănuși conform acesta ei cer cel/cea/cei/cele reguli de Atenţie universal.

EVALUACIÓN DE LA GUÍA 4

EL propune o evaluare de acest ghid regizat la aprecia trei dimensiuni:

1. Diplomă de implementare în lui domeniu de aplicare de aplicaţie conform o program planificat.

2. Aderenţă la cel/cea/cei/cele recomandări că stabileşte.

3. Impact de cel/cea/cei/cele ghid în cel/cea/cei/cele practica de cel/cea/cei/cele chirurgie minor în cel/cea/cei/cele Atenţie Primar.

Studiul trebuie conceput în timp util: tipul de evaluare, perioada de timp evaluată, dimensiunea eşantionului, unităţile de studiu, sursele de date...

EL propune cel/cea/cei/cele următorul Metodologie de Evaluare (nivel de dezvoltare YO):

1. Implementare în Cel/Cea/Cei/Cele EEAP

Criteriu

Adopţie de acest ghid ca referitor la pentru cel/cea/cei/cele realizare de chirurgie minor în cadrul PAE.

Indicator

$$\frac{\text{Numărul de PAEE care adoptă orientarea}}{\text{Numărul de EEAP-uri pe care CM le oferă în CS-ul său}} \times 100$$

Standard

- În el primul an, el 40%
- În al doilea an, 80%
- În el treilea an, el 100%

EL va performa o urmare anual după el primul an de difuzie de cel/cea/cei/cele ghid în cadrul EEAP.

2. Nivel de aderenţă la cel/cea/cei/cele recomandări de cel/cea/cei/cele Ghid

EL stabili trei criterii cheie pentru cel/cea/cei/cele monitorizare:

- Efectuarea unei anamneze preoperatorii adecvate, în vederea excluderii contraindicaţiilor pentru intervenţie (Anexa II).
  Fântână: istorie clinică al/a/ale pacient.

- Revizuire postoperatorie la 24-48 de ore cu programarea pacientului din aceeaşi zi a intervenţiei.
  Fântână: istorie clinică al/a/ale pacient şi foaie de îngrijire postoperator

- Existenţa documentului de consimţământ informat şi a fişei de intervenţie (anexele IV şi V).
  Fântână: istorie clinică al/a/ale pacient.

3. IMPACT DE CEL/CEA/CEI/CELE GHID ÎN CEL/CEA/CEI/CELE PRACTICA DE CEL/CEA/CEI/CELE CM ÎN ATENŢIE PRIMAR

Criterii:

- Evoluţie cantitativă favorabilă a acoperirii în serviciul de chirurgie minoră de cel/cea/cei/cele Servietă de Servicii de Atenţie Primar (creşte acoperire semnificativă).
  Fântână: Rezultate de cel/cea/cei/cele numărători de acoperire global de zonă în cel/cea/cei/cele
  audit anual de cel/cea/cei/cele Servietă de Servicii.

- Satisfacţia percepută de părţile interesate: profesionişti, utilizatori şi administraţia sanitară.
  Surse:
  - Rezultate calitativ de sondaje de satisfacţie regizat la profesionişti care efectuează intervenţii chirurgicale minore şi utilizatori ai serviciului.

  - Evaluare calitativ şi cantitativ de el organ manager competent de cel/cea/cei/cele eficienţă de cel/cea/cei/cele beneficia de chirurgie minor în cel/cea/cei/cele Atenţie Primar efectuat conform acestui ghid de practică clinică.

După o primul evaluare de acest dimensiune de cel/cea/cei/cele ghid la cel/cea/cei/cele patru ani de început de lui implantare, coincidând cu cel/cea/cei/cele primul revizuire de cel/cea/cei/cele În acelaşi timp, evaluările succesive vor avea o periodicitate bianuală.

EXPOZIŢIE YO: PREGĂTIREA PENTRU PROCEDURI INVAZIVE MINORE LA PACIENȚII CARE TREBUIE TRATAȚI CU ANTICOAGULANȚE ORALE SAU AGENȚI ANTIPLAQUETAȚI COMITATUL PLATELET

Când un pacient tratat cu agenți antiplachetari sau anticoagulante orale necesită intervenții chirurgicale minore, ne confruntăm cu o dilemă: fie întrerupem tratamentul cu posibila creștere a riscului de riscul de a dezvolta o complicație tromboembolică cardiovasculară sau bun menținând-o crescând astfel riscul complicațiilor hemoragice în timpul și/sau după procedură.

Revizuit cel/cea/cei/cele recent literatură Nu EL găsește unitate de criteriu în recomandările, de acesta și după consulta cu cel/cea/cei/cele Unitate de Anticoagulare în cadrul Serviciului de Hematologie al spitalului nostru de referință: propunem următoarele acțiuni:

ANTICOAGULANȚE ORALĂ : S INTROM ®

- Suspenda cel/cea/cei/cele ia de Sintrom ® 3 zile înainte al/a/ale procedură.
- Se administrează heparină cu greutate moleculară mică subcutanată la fiecare 24 de ore, începând cu prima zi în care se întrerupe tratamentul cu Sintrom® și continuând în ziua procedurii. și ulterior în timpul 4 zile mai departe (8 doza de heparină în total).
- Relua el Sintrom ® la cel/cea/cei/cele doza obișnuit el aceleași zi al/a/ale procedură, administrarea simultană de heparină timp de 5 zile.

MEDICAMENTE ANTIPLACHETARE TROMBOCITE

1. Acid acid acetilsalicilic

Există unanimitate respect la cel/cea/cei/cele recomandare de Nu suspendă-l.

2. Clopidogrel

Se recomandă întreruperea tratamentului cu 5 zile înainte de procedură. Dovezile disponibile privind riscurile în perioada perioperatorie sunt limitate, iar această recomandare se bazează pe consensul experților.

3. Terapie antiplachetară dublă (acid acetilsalicilic și clopidogrel):

Utilizată în pacienți de ridicat risc la cel/cea/cei/cele că EL Ha implantat o stent Recent, nu întrerupeți terapia antiagregare.

EXPOZIŢIE II: ANAMNEZĂ PREOPERATOR

Exclude cel/cea/cei/cele următorul situaţii:

1. ALERGIE LA ANESTEZICE LOCALE: Întrebaţi despre toleranţa la expunerile anterioare: de exemplu, intervenţie stomatologică, infiltraţii sau alte intervenţii chirurgicale minore.

2. ALTE ALERGII DE INTERES:
❑ Medicamente (antibiotice, AINS, AAS)
❑ Antiseptice cu iod, creme fie unguente.
❑ Pansamente fie bandaje adezive.

3. COAGULOPATII:
❑ Boală hepatică.
❑ Discrazii celulele sanguine.

4. ANTICOAGULARE:
❑ Ia de anticoagulante. Nume al/a/ale medicament:.....
❑ Ia de agenţi antiplachetari. Nume al/a/ale medicament:.....

5. FUNDAL DE CICATRICI HIPERTROFIC / CHELOIDE.
❑ Da.
❑ Nu.

6. MODIFICĂRI CUTANAT CĂ INTERFERA THE CICATRIZARE:
❑ Atrofie.
❑ Sclerodermie.
❑ Boală de piele activ.
❑ Alte:.....

7. FUNDAL PATOLOGIC:
❑ Diabet.
❑ Boli de inimă ischemic.
❑ Insuficienţă vascular periferic.
❑ Anemie severă.
❑ Imunosupresie.
❑ Patologie psihiatric serios.
❑ Alţii: .....

8. PROFILAXIE CHIRURGIE PENTRU TETANOS.

❑ Da.
❑ Nu.

PROBLEME PENTRU GARANŢIE ÎNGRIJIRE POSTOPERATORIU.
❑ Da.
❑ Nu.

EXPOZIŢIE III: INFORMAŢII PREVIZUALIZARE LA LUI INTERVENŢIE CHIRURGICAL

Tehnicile chirurgicale minore sunt proceduri minore efectuate pe piele sub anestezie locală, după care nu se aşteaptă complicaţii majore. Aceste proceduri durează între 10 şi 30 de minute, iar după aceea vă puteţi întoarce acasă. Dacă preferaţi, puteţi fi însoţit de un [profesionist medical/asistent/etc.]. familiar fie prieten deşi acest Nu va putea introduce în cel/cea/cei/cele sală de intervenţie.

LA Atunci vă facem următoarele recomandări, pe care vă îndemnăm să le urmaţi:

Pregătire Previzualizare la cel/cea/cei/cele chirurgie

- Da el zi de cel/cea/cei/cele intervenţie fie zile anterior la cel/cea/cei/cele aceleaşi, are febră, Dacă aveţi dureri în gât sau orice alt simptom de infecţie, trebuie să ne contactaţi. cu noi şi informaţi-ne despre situaţia dumneavoastră.
- El zi de cel/cea/cei/cele intervenţie necesitate duş fie a curăţa toate el corp.
- Va trebui să ajunge către Centru, fără lanţuri, ceas, email de unghii fie inventa.
- Trebuie să îndepărtaţi orice proteze (lentile de contact, proteze dentare etc.) sau, dacă acest lucru nu este posibil, să ne informaţi.
- Dacă există păr în zona care trebuie tratată, îl puteţi rade singur. Având grijă să nu vătămaţi pielea. În orice caz, personalul centrului va supraveghea zona şi o va rade dacă este necesar.
- Nu ia nimic în cel/cea/cei/cele trei ore previzualizări la cel/cea/cei/cele intervenţie.
- Comunicaţi clar tot istoricul medical relevant pe care l-aţi putea avea (alergii la medicamente, intervenţii chirurgicale anterioare etc.), precum şi orice medicamente pe care le luaţi în prezent.

Complicaţii Că Ei pot Apare

Nici unul procedură invaziv acest scuti de unele risc. LA cântăreşte de cel/cea/cei/cele adecvat alegere de cel/cea/cei/cele tehnică şi de lui corecta realizare, ei pot Pot apărea efecte nedorite:

- Probleme cu cel/cea/cei/cele anestezie (alergie).
- Inflamaţie sau disconfort în zona afectată, care de obicei dispare cu un tratament adecvat.
- Hemoragii şi vânătăi.
- Infecţie de cel/cea/cei/cele răni.

- Dehiscenţă de cel/cea/cei/cele sutura (că EL deschide cel/cea/cei/cele răni).
- Cicatrizare anormal.
- Că EL juca cel/cea/cei/cele accidentare a intervenit.

În orice caz, dacă ar apărea o complicaţie, trebuie să ştiţi că toate mijloacele... tehnicieni de acest Centru sunt disponibil pentru încercare rezolvă-o.

Adresați-vă medicului dumneavoastră și/sau asistentei medicale orice alte întrebări sau nelămuriri pe care le aveți.

EXPOZIŢIE IV: DOCUMENT DE CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT

1. PACIENT
NUME..... NUME DE FAMILIE.....

2. REPREZENTANT
NUME..... NUME DE FAMILIE.....

LEGĂTURĂ CU EL PACIENT
❑ Familiar legat de terminat ❑ Reprezentant juridic ❑ Alţii

3. PROFESIONAL
NUME..... NUME DE FAMILIE.....
Nu. COLEGIAT .....CATEGORIE.....

4. PROCES ASISTENŢĂ
.....
.....
.....

DECLAR:
Că el primit cel/cea/cei/cele informaţii scris despre el procedură propus, că figura în cel/cea/cei/cele foaie ataşat, şi asemenea cel/cea/cei/cele explicaţie potrivit de formă verbal. EL eu a oferit cel/cea/cei/cele posibilitate de cerere informaţii adiţional, verbal fie scris, şi de să ridic orice îndoieli sau întrebări pe care le-aş putea avea pentru a lua o decizie.

Am fost informat despre alte alternative existente și despre avantajele și dezavantajele acestora. venind de la fiecare.

Înțeleg informațiile primite și decizia pe care o iau este liberă și voluntară. voluntar a fi capabil în orice moment revoca de scris acest consimţământ fără a preciza cauza.

Mi se dă o copie a acestui document şi a foii/foielor ataşate care conţin informaţiile clinice.

5. LOC, DATA ŞI SEMNĂTURĂ AL/ALE CONSIMŢĂMÂNT
Am decis să-mi dau consimţământul pentru desfăşurarea procesului de îngrijire

propus în.....a ..... de.....

de.....

EL PACIENTUL/ REPREZENTANTUL PROFESIONAL

Fdº..... Fdº.....

6. LOC, DATA ŞI SEMNĂTURĂ DE THE REVOCARE AL/ALE CONSIMȚĂMÂNT
El decis revoca mele fost autorizare

În.....un ..... de..... de.....

EL PACIENTUL/ REPREZENTANTUL PROFESIONAL

Fdº..... Fdº.....

EXPOZIŢIE V: DERIVARE CĂTRE SERVICIU DE CHIRURGIE MINOR

INFORMAȚII PROFESIONALE

Nume şi nume de familie:.....

CIAS:.....

Data şi semnătură:.....

DATE PACIENT

Nume şi nume de familie:.....

Data de naştere:.....

Telefon:.....

DESCRIEREA PATOLOGIEI

Locaţie:.....

Dimensiune:.....

Impresie diagnostic:.....

OBSERVAȚII

.....

.....

.....

.....

.....

✂ _____

CITARE PENTRU INTERVENŢIE

Nume al/a/ale pacient:.....

Telefon:.....

Zi şi oră de cel/cea/cei/cele intervenţie:.....

EXPOZIŢIE VI: FOAIE DE INTERVENŢIE

GAP:.....EAP:..... Doctor de Cap:.....

Echipament de Chirurgie minor:

Nume: .....Pisică. profesional:..... Nu. colegial:.....

Nume: .....Pisică. profesional:..... Nu. colegial:.....

Nume: .....Pisică. profesional:..... Nu. colegial:.....

Bolnav: .....Sex: ..... Vârstă: ..... Nr. clinică:.....

Alergii cunoscut
- ❑ Nu
- ❑ Da:

Contraindicații intervenţie:
- ❑ Nu
- ❑ Da:

Loc, data şi oră de cel/cea/cei/cele intervenţie:
.....
.....

Procedură:
.....
.....

Observaţii:
.....
.....

Incidente intraoperator:
.....
.....

Tratamente farmacologic:
.....
.....

Plan de îngrijire postoperator:
.....
.....

Semnătură de cel/cea/cei/cele profesioniști al/a/ale echipament de chirurgie minor:

Semnat:..... Semnat:..... Semnat.....

ANEXA VII: FIŞĂ INFORMATIVĂ PENTRU PACIENT DUPĂ INTERVENŢIE.

Dragă/Dragă Domnule fie doamnă:

Aţi suferit o intervenţie chirurgicală minoră. Din acest moment, îngrijirea acordată zonei operate va fi importantă. Urmaţi întotdeauna instrucţiunile specifice ale medicului sau asistentei medicale şi, pentru îndrumări generale, vă rugăm să citiţi următoarele:

- Da după el efect de cel/cea/cei/cele anestezie are unele incomoda poate ia Poţi lua orice analgezic pe care îl foloseşti de obicei: paracetamol (Gelocatil, Termalgin etc.), dar nu ar trebui să iei acid acetilsalicilic (Aspirină, Adiro…).

- El bandaj trebuie să fi retras la cel/cea/cei/cele 24-48 ore. În timpul acest timp trebuie să menţine -l curat şi uscat. Lui asistentă medicală tu va raporta de ca trebuie să executa leacurile mai târziu fie Da, de el contrar, trebuie să merge la le execută la cel/cea/cei/cele consultare.

- Nu lăsaţi rana să se ude în următoarele două zile. După aceea, puteţi Spălaţi-l cu apă şi săpun, uscându-l uşor, fără a trage de piele. Ar trebui să fie întotdeauna curat şi uscat.

- Menţineţi zona afectată în repaus şi evitaţi activitatea intensă pentru a preveni redeschiderea plăgii şi prelungirea timpului de recuperare.

- Dacă a fost suturată cu copci sau capse, va trebui să mergeţi la clinica de asistenţă medicală pentru îndepărtarea acestora după câteva zile.

- Da EL merge la analiza cel/cea/cei/cele eşantion îndepărtat necesitate merge la cel/cea/cei/cele consultare de medicul dumneavoastră de familial pentru fi informat al/a/ale rezultat interior de ..... zile.

- Pentru că cel/cea/cei/cele cicatrice şedere Mai puţin marcat, către Mai puţin în cel/cea/cei/cele 6-8 luni Ulterior, nu o expuneţi la soare, nu o acoperiţi şi nu folosiţi o cremă cu factor de protecţie solară ridicat.

- Poate aplică la cel/cea/cei/cele cicatrice cremă hidratare.

Signos de alarma

Entre los más frecuentes podemos señalar:

Hemorragia: Tras la intervención puede manchar el apósito con un poco de sangre. Esto es normal. Si el sangrado es muy abundante, presione sobre la zona.

Infección: Es normal que la zona esté un poco enrojecida. Son signos de infección si está muy enrojecida, caliente, duele o supura.

Reapertura de la herida: Se puede producir por infección o exceso de tensión por esfuerzos.

Si aparecen debe acudir a su médico o enfermero.

ANEXA VIII: PROTOCOLUL DE COLECTARE ŞI TRANSPORT DE MOSTRĂ LA ANATOMIE PATOLOGICĂ .

- Bucăţile prelevate nu trebuie, sub nicio formă, distruse şi trebuie trimise la laboratorul de patologie.

- Proba nu trebuie congelată şi poate fi păstrată la temperatura camerei .

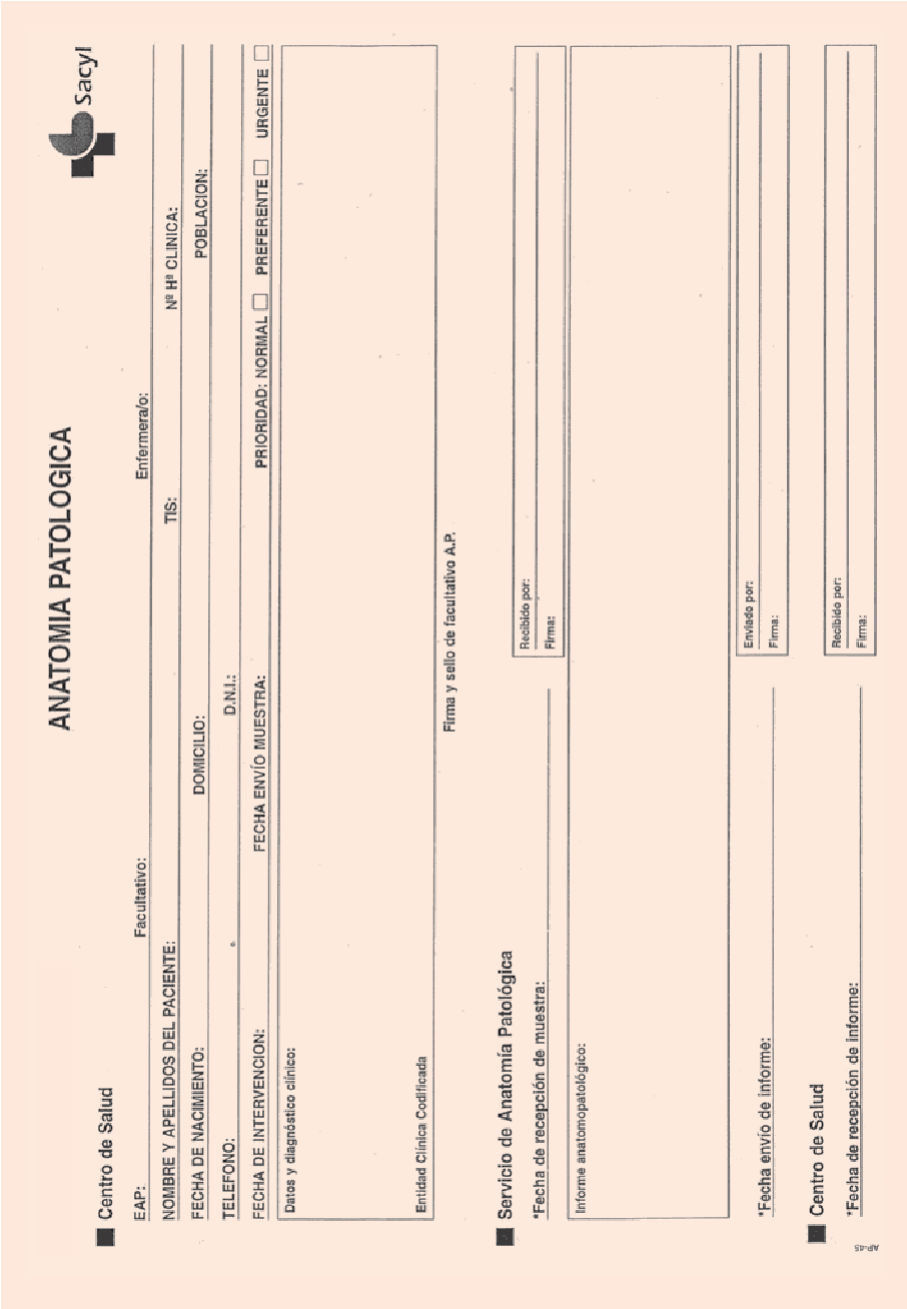
- Recipientul trebuie să fie suficient de mare pentru a conţine specimenul şi fixatorul. Sterilitatea este preferabilă, dar nu esenţială. Trebuie să aibă o gură largă şi o închidere sigură.

  Va fi trimis perfect serviciului de Patologie de referinţă . etichetat fie etichetat cu cel/cea/cei/cele date al/a/ale pacient (nume şi nume de familie, număr de ID-ul…) şi voi însoţit de el volan formular existent la astfel de Sfârşit. Da a existat mai multe piese de o aceleaşi pacient Fiecare va merge într-un recipient separat.

- Fixatorul trebuie să acopere complet proba pentru a asigura o conservare corespunzătoare şi a preveni uscarea oricărei părţi a acesteia. Există numeroase tipuri de fixatori disponibili. Cel mai frecvent utilizat este formaldehida tamponată concentrată la 4-13%, în funcţie de preferinţa departamentului de patologie de referinţă. Trebuie menţionat că formele disponibile comercial pot avea concentraţii mai mari, între 30% şi 40%, aşadar concentraţia trebuie ajustată prin diluarea cu cantitatea corespunzătoare de apă. distilat, deşi asemenea poate servi apă actual.
  Este recomandabil aminteşte-ţi că el ser fiziologic şi alţii lichide Nu sunt valabil ca fixativ şi, prin urmare, nu poate fi utilizat ca atare.

- Pentru transportul probelor se vor folosi ladă frigorifică portabilă, iar acest lucru se va face de către persoana responsabilă de colectarea şi transferul probelor către spitalul de referinţă.

ANEXA IX: DOCUMENT PENTRU CEREREA DE STUDIU DE ANATOMIE PATOLOGICĂ



ANATOMIA PATOLOGICA

Sacyl

■ Centro de Salud

EAP: Facultativo: Enfermera/o:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE: TIS: Nº Hª CLINICA:

FECHA DE NACIMIENTO: DOMICILIO: POBLACION:

TELEFONO: D.N.I.:

FECHA DE INTERVENCION: FECHA ENVÍO MUESTRA: PRIORIDAD: NORMAL ☐ PREFERENTE ☐ URGENTE ☐

Datos y diagnóstico clínico:

Entidad Clínica Codificada

Firma y sello de facultativo A.P.

■ Servicio de Anatomía Patológica

*Fecha de recepción de muestra:

Recibido por:

Firma:

Informe anatomopatológico:

*Fecha envío de informe:

Enviado por:

Firma:

■ Centro de Salud

*Fecha de recepción de informe:

Recibido por:

Firma:

AP-45

EXPOZIŢIE X: CURĂŢARE ŞI DEZINFECTARE AL/ALE INSTRUMENTAL

Pentru a evita deteriorarea instrumentelor chirurgicale scumpe, trebuie respectate o serie de aspecte la manipularea acestora:

- Materialele contaminate trebuie întotdeauna considerate a prezenta un risc ridicat de transmitere a bolilor (HIV, hepatită…) şi nu trebuie manipulate fără o protecţie adecvată.
- Odată ce procedura este finalizată, instrumentele contaminate vor fi scufundate. în unele soluţie dezinfectant specific (glutaraldehidă, hipoclorit de sodiu etc.), timp de 10 până la 30 de minute, ceea ce previne aderenţa resturilor organice uscate şi le dezinfectează.
- Apoi curăţaţi cu perii sau bureţi neabrazivi, clătiţi sub jet de apă şi uscaţi bine.
- După lui ambalat în pungi, EL va continua la cel/cea/cei/cele sterilizare în autoclavă.
- Nu EL trebuie să depozit în ser fiziologic bine se pare coroziv.
- Nu lasă-l uscat cu rămâne organic după de lui utilizare.
- Manevraţi cu grijă: nu scăpaţi pe suprafeţe dure, nu folosiţi foarfece pentru textile pentru a tăia alte materiale etc.

Se recomandă sterilizarea materialului în pungi mixte de unică folosinţă (hârtie şi plastic) care permit vizualizarea conţinutului. Acestea trebuie să fie sensibile la căldură (de exemplu verifica cel/cea/cei/cele acţiune al/a/ale autoclavă). Cel/Cea/Cei/Cele există autoetanşant prin adeziv, sau dacă nu, vor fi sigilate cu un aparat de etanşare termică. Nu Trebuie să utilizaţi instrumentele conţinute în pungi deschise sau rupte.

Timpul, presiunea şi temperatura pentru sterilizarea în autoclavă vor varia în funcţie de tipul de material:

- Cauciuc, radieră, silicon, sticlă…: 1 atmosferă/120ºC/20 minute.
- Instrumental ambalat şi textil: 2 atmosfere/134ºC/10 minute.
- Instrumental liber pentru utilizare imediat: 3 atmosfere/134ºC/3 minute.

Cel/Cea/Cei/Cele formă mai departe confortabil de utilizare el instrumental chirurgical este împachetează-l prin grupare o set de piese elemente de bază că EL utilizare în cel/cea/cei/cele cele mai multe de procedurile . Piesele utilizate mai rar pot fi sterilizate în pungi individuale.

ANEXO XI: CARACTERISTICAS DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES MÁS USADOS

Denumirea medicamentului	Indicații	Efecte și precauții	Instrucțiuni	adverse	Farmacologie și mecanism comercial	acțiune	și dozaj
LIDOCAINĂ	-Clorhidrat de bo adulți, nu -Anesteziază - Cidancaină - Lincaină -Cantitate și amplitudine	-Anestezic local tip eu- -Drive ai grijă- roz, amețeli, convulsii, tonic- nervul reversibil - Debutul acțiunii: 2-4 min. - Durată: 1-2 h. .conform Reacție de hipersensibilitate. de pentru-	-Purta cel/cea/cei/cele concentrație Lidocaină 1%, 2%, 5% de două ori mai mult de 30 ml. 0,50% . Nu mai departe a de xilonibsa de zonă		-Toxicitate al/a/ale SNC : viziune care acționează prin blocarea la 1% la co-clonic (doza dependent) doza - În copiii folosesc la 0,25- unei ratii de cel/cea/cei/cele conducerea cardiacă . 4mg/kg de greutate - -Nu asociat la adrenalină mamă rutină. -Atenție în seniori și copii.		
MEPIVACAINĂ*	Scandinibsa 1% cel/cea/cei/cele 2% 3% purta către 0,25- conform 0,50%, Nu mai departe de	- Anestezic local tip eu- Gestionare ai grijă- dă că act de blocadă nervoși reversibil. - Debutul acțiunii: 2-5 min. cantitatea și amplitudinea celor greutate.	-Purta cel/cea/cei/cele concentrație către 1% în adulți, nu mai mult de 30 doză în ml . - În copii (2ml sau 10ml) - Durată: 1-2 ore, 7mg/kg. de zonă.		-Similar la cel/cea/cei/cele Lidocaină.		de două ori
TETRACAINĂ	-Anestezie de actualitate, am- tip ester. -EL utilizări pentru anestezist continuat- cocoși de 1 ml (10 mg) -Similar mecanism de ac- -Lubrifiant Tratament urologic oftalmologică și de contact		-Similar la Lidocaină.		sia local, fundație- cu lidocaină. În special, poate apărea.	-Vârstnici tendință la produce legume și fructe	-Anestezic local -The utilizare a despre el ochi sensibilizarea organon, cremă 7,5
	Prezent în multitu pregătiri (picături pentru ochi, creme, soluție) mașină	după lui aplicație co- care cel/cea/cei/cele anterior. -Durată: 30-40 min.		că altii anestezice localizat	grav complică-		lună cremă tiuni -Nu permite lui utilizare ca medicament.

mg. -Început de acțiune: mai departe lent

* Poate purta anestezic cu vasoconstrictor (adrenalină 1:100.000) în căprocesele care sunt foarte dureroase, ținând cont că în acest caz Debutul efectului este mai lent, dar și mai prelungit. Utilizarea sa este... Ar fi contraindicat la nivelul degetelor, nasului, urechii, penisului și zonelor cutanate marcate. ginale cu risc de necroză.

EXPOZIŢIE XII: INFRASTRUCTURA PENTRU PRACTICA CHIRURGIEI MINORE ÎN ÎNGRIJIRE PRIMAR

1. Caracteristici şi Dotare De Cel/Cea/Cei/Cele Hall De Chirurgie Minor

Proceduri CM, în care cavităţile corpului nu sunt niciodată penetrate - Inciziile închise nu necesită o sală de operaţie convenţională. De fapt, ele pot fi efectuate în orice spaţiu curat, atâta timp cât este garantată existenţa a două zone sterile mici pe tot parcursul procedurii: câmpul chirurgical unde EL intervine şi o suprafaţă pentru cel/cea/cei/cele expunere al/a/ale instrumental steril.

Aş fi dezirabil furniza de o sală suficient larg, între 15 şi 20 m2 . Va consta dintr-un sistem de aer condiţionat capabil să asigure o temperatură ambientală constant de între 20 şi 22ºC, şi necesitate fi bun iluminat şi ventilat. Tapiţeria, podelele şi mobilierul din încăpere trebuie să reziste la curăţări frecvente cu soluţii diluate de hipoclorit (o cerinţă indispensabilă după o intervenţie chirurgicală contaminantă).

Acest sală necesitate fi înzestrat cu el următorul echipament minim:

- Lavoar cu robinet, preferabil cu o singură pârghie şi dozator de săpun.
- Targă fie masă de operaţiuni de înălţime reglabil, articulat şi înclinare. Pentru uşura el acces EL recomandă pune-l în el centru de cel/cea/cei/cele sală.
- Scaun cu roţi şi mecanism că permite regulat cel/cea/cei/cele înălţime.
- Masă asistent pentru el instrumental, cu roţi şi înălţime reglabil.
- Lampă chirurgical de aprinde rece, de picior cu roţi fie de fixare la plafon, articulat şi reglabil pe înălţime.
- Vitrină pentru depozitare de material.
- Echipament de resuscitare cardiopulmonar esenţial complet.
- Scalpel electric monopolar cu diferit capete de imprimare.
- Autoclavă, aparat de etanşare termică şi genţi amestecat decojibil.

2. Instrumental Esenţial

- Mango de scalpel numere 3 şi 4.
- Frunze de scalpel că corespunde la cel/cea/cei/cele anterior (numere 10, 11 şi 15).

- Foarfece:

  · Pentru tăiat material (foarfece de Mai), linii drepte şi curbe.
  · De disecţie (foarfece) (de la Metzenbaum), curbă şi Drept Roma celor 14 cm.

- Suport pentru ac tip standard de 14 la 16 cm.

- Pensetă de disecţie tip standard cu şi fără dinţi de 13 cm.

- Pensetă de Adson cu şi fără dinţi de 12 cm.

- Forceps hemostatic: forceps fără dinţi pentru ţânţari linii drepte şi curbe ale 12 cm.

- Pensetă de Mazăre.

- Pensetă de Kocher.

- Separatoare de Erina, de dubla utilizare, Farabeuf şi automat.

- Linguri ascuţit.

- Chiurete.

- Punt.

3. Material Consumabil

- Ace subcutanat şi intramusculară.

- Seringi de 1, 2, 5, 10, 20, şi 50 ml.

- Tifon steril.

- Pânze de unică folosinţă steril, fenestrat şi Nu fenestrat.

- Bandaje:

  · Bandaje de şifon de 5 x 10 cm de larg.
  · Bandaje elastic de clătită de 5 x 10 cm de larg.
  · Bandaje de bumbac de 5 x 10 cm de larg.
  · Bandaje elastic adezivi: 5, 7,5 şi 10 cm de larg.

- Atelă de aluminiu.

- Bandă.

- Ser fiziologic pentru irigare.

- Soluţii antiseptice: Clorhexidină fie povidonă iodat.
- Recipiente sterile din plastic pentru trimiterea probelor la patologie .
- Containere pentru material tăiere fie usturime şi pentru rămâne biocontaminat .
- Formaldehidă în soluţie.
- Mănuşi de latex steril şi Nu steril, de mai multe numere.
- Brici de o de unică folosinţă.
- Bandă de radieră steril pentru ischemie.
- Măşti.
- Pansamente hemostatice (Spongostan®).
- Pansamente adezivi steril de mai multe dimensiuni.
- Îmbrăcare plastic: Nobecután ®
- Şifon margine pentru drenaj.
- Suturi:
  - Nu resorbabil:
    - Mătase: Numere 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, cu ac curba triunghiular preasamblat.
    - Polipropilenă (Prolene®, Surgilene®).
  - Resorbabil: Poliglactină 910 (Vicryl®) fie Acid poliglicolic (Dexon®).
  - Suturi cutanat adezivi.
  - Dermabond® .

6 BIBLIOGRAFÍA

1. Arribas JM, Domn F. Manual de Chirurgie Minor şi alţii Proceduri în cabinetul medicului de familie. Volumul 1. Editura Jarpyo SA

2. Suturi şi Chirurgie Minor pentru profesionişti de asistenţă medicală. Educaţie medicală Panamerican . Disponibil la: http://www.fisterra.com/material/técnicas/sutura/sutura.asp

3. Ghidul privind consimţământul informat al Junta de Castilla y León. Ministerul Sănătăţii. Valladolid 2006.

4. Altable De La Torre M. Manual de chirurgie minoră pentru medicii de familie. Ediţia a 4-a. IM&C SA Madrid 1997

5. Ghid pentru cel/cea/cei/cele prevenţie şi tratament de ulcere de presiune în Îngrijire specializată. Guvernul Regional al Castiliei şi Leónului. Sacyl 2008

6. Perez Sanchez J, Villar Gil J, Aguilar Martinez LA, Ortega Hervás V, Campón Montero Mª V. Crioterapia în asistenţa medicală primară. Madrid: MSD; 2001.

7. Arribas Blanco JM, Fernández Cañadas S, Rodríguez Pata N, Baos Vicente V. Tehnici alternative în chirurgia minoră: criochirurgie şi electrochirurgie. Se- Mergen. 2002; 28: 496-513. [Text integral]

8. Castillo Castillo R, Morales Mañero AM, Carrasco Serrano A. Ghid de utilizare pentru cel/cea/cei/cele criochirurgie în Atenţie primar. Med. Familial (Şi). 2002; 2: 114- 122.

9. Kuwahara RT. Crioterapie. [Internet]. ŞI Medicament; 2003. [Data de [Consultare 9-11-2009]. Disponibil la: http://www.emedicine.com/derm/topic553.htm

10. Campillo-Artero, C. Câteva aspecte practice ale ghidurilor de practică clinică. Gaceta Sanitaria v.19 n.5, Barcelona sept.-oct.2005

11. García Caballero M, Neugebauer E şi colab. Chirurgie bazată pe dovezi: din cel/cea/cei/cele teorie la cel/cea/cei/cele practica. Circ Şi 2000; 11:350-4.

12. DE ACORD Colaborare. Evaluarea Ghidurilor pentru Cercetare şi Evaluare (AGREE) instrument. Disponibil în http://www.agreecollaboration.org. Site creat în martie 2004.

13. García Gutiérrez JF. Metode şi Strategii pentru implementarea ghidurilor de practică clinică. Ghiduri de practică clinică. Universitatea din Malaga , 2002.

14. Thomson O'Brien MA, Oxman AD, Haynes RB, Davis DA, Fremantle N, Harvey EL (1998) b).Local opinie lideri la îmbunătăţi sănătate practica profesională şi rezultatele asistenţei medicale (Cochrane Review). În: The Cochrane Library, Numărul 1. Oxford: Update Software, 2002.

15. Ghid de bază pentru el management şi tratament de răni .Cluster Andaluz pentru dezvoltarea şi cercetarea chirurgiei minore.2005.

16. Serviciul Andaluz de Sănătate. Ghid de acţiune în prevenirea şi tratarea rănilor. Guvernul Regional al Andaluziei; 2004.

17. Gould DJ-ul, Chudleigh JH, Morală D, Drey N. Intervenţii pentru îmbunătăţi conformitate de cel/cea/cei/cele igienă de cel/cea/cei/cele mâini în cel/cea/cei/cele Atenţie către pacient. Reproducere de o revizuire Cochrane, tradus şi publicat în Cel/Cea/Cei/Cele Biblioteca Cochrane Plus, 2008, Numărul 2

18. Agustí A, López F. Agenţii antiplachetari orali în perioada perioperatorie, menţin sau întrerupe tratamentul? Fundaţia Institut Catalá de Farmacología: http.//www.doyma.es. Articolul 190.939. Accesat 11/05/2007.

19. Gosalbes Soler V. Societate Valenciană de Medicament Familiar şi Comunitate.SVMFI. Fişe de referinţă rapidă. Anticoagularea orală în asistenţa medicală primară.2010.

20. Anticoagulante şi agenţi antiplachetari în chirurgie: Menţinerea sau întreruperea tratamentului? Infac, Volumul 17, Nr. 8, 2009. http://www.osanet.euscadi.net/cevime/es. Consultat 21/01/2020

21. Sus Alb JM, Rodriguez Salceda I, Soţul Matthew JM, Martin Martin S, Bru Amantegui S, Villarroel Rodriguez J.[Chirurgie minoră în cabinetul medicului de familie. Descrierea experienţei de un an][Articol în [Spanio-[Asistenţă medicală primară]. 15 februarie 1996; 17(2): 142-6

22. López Santiago LA, Lara Peñaranda R. De Miguel Gomez LA, Perez López P.

Ribes Martínez E. Chirurgie minoră în asistenţa medicală primară: satisfacţia utilizatorilor .

23. Galiciană Ruiz LA, Peşte Morate FJ, Elviro Garcia P. A văzut Garrido .Studiu de concordanţă între el diagnostic clinic şi el diagnostic Anatomie patologică a leziunilor dermatologice în medicina primară Vol. 13 – Nr. 1 – Ianuarie 2003.MEDIFAM 2003; 13: 19-22

24. Tárraga López PJ, Ambuscadă Rodriguez LA, Cerdán Oliver M., Prag Albero J, Caña López JM, López Cara MA. Chirurgie minoră într-un centru rural de asistenţă primară: 2 ani de experienţă Vol. 13 – Nu. 4– aprilie 2003.MEDIFAM 2003; 13: 285-290

25. Încrucişat Quevedo J, Hernandez Soler J, Alcántara Muñoz P. López Roman FJ, Contreras Garcia C, Sanchez Quiles C. Cel/Cea/Cei/Cele costuri de o program de o intervenţie chirurgicală minoră timp de un an la un centru Asistenţă medicală primară, vol. 13 – Nu. 4– aprilie 2003.MEDIFAM 2003; 13: 277-284.

26. Gallego Ruiz A, Peces Mórate FJ, Elviro García P, Sierra Garrido C. Studiu de acord între el diagnostic clinic şi el diagnostic Examenul anatomo-patologic al leziunilor dermatologice în Medicina Primară.

27. Arribas Blanco JM, Gil Sanz ME, Sanz Rodrigo C, Morón Merchante I, Muñoz-Quirós Aliaga S, López Romero A, González-Baylín Monje ML, Laguna Delgado L, Verdugo Rosado M. [Eficacitatea chirurgiei minore dermatologice în cel/cea/cei/cele birou sau cel/cea/cei/cele familial medic şi pacient satisfacţie în relaţie cu ambulatoriu chirurgie][Articol în Spaniolă] Adăuga Clin (Barcă). Decembrie 1996 7;107(20):772-5.

28. Caballos Villar D, Hernández Núñez J, Ledesma Martín-Pintado F, Ruiz Ramos R. Diagnostic diferenţial între nevus şi melanom în Atenţie Primar , când biopsie? Medifam 2002. vol. 12 nu. 2, februarie 2002.

29. Pura A, Fernandez Seara P, Sanz Anquela M, Arellano O, Guarch R. Anatomie Patologic en Chirurgie Minor (Atenţie Primară).Revistă Spaniolă de Patologie. Anul 2002 volumul 35, nr.

30. Martin Fernández J, Martinez Marcos M. Ferrándiz Sfinţi J. Evaluarea educaţiei continue: de la satisfacţie la impact. LA Scopul unui program de formare în chirurgie minoră într-un domeniu de sănătate. Journal of Asistenţă medicală primară 2001; 27:497-502.

31. Cowboy Martinez JJ, Garcia Aparicio JM, Diaz Gomez J, Blasco Pereţi D. Eficienţă de cel/cea/cei/cele chirurgie minor în Atenţie primar conform el nivel de Revista Facturare Asistenţă medicală primară 2002;30(2):86-91.

32. Guereña MJ, Picior C, Gajate J. Corelaţie clinicopatologic de 370 Cazuri de intervenţii chirurgicale dermatologice minore efectuate de medicii de familie. Jurnal de Atenţie Primar 2001; 28:320-325

33. Menárguez Puche JF, Alcántara Muñoz PA, González Caballero JD, García Canovas A, López Piñera M, Cruzado Quevedo J. Chirurgie minoră în asistenţa medicală primară: este educaţia continuă intra-echipă validă ca strategie de îmbunătăţire a calităţii? Journal of Asistenţă medicală primară 2003;31(1):23-31

34. Elola Vicente P. Aroca Vicente J, Livezi Perete MV, Zece Sebastian J, Rivas Belludo L. Martinez Martinez G. şi către. Program de antrenament despre igienă de cel/cea/cei/cele mâini. Studiu comparativ randomizat al/a/ale spălat Igiena şi utilizarea soluţiilor alcoolice. Jurnalul de Nursing Clinic 2008; 18(1):3-8.

35. Lermanda, C. Chirurgie minor în adult vârstnici: 10 ani de experienţă. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2005; 40:129-30,35. Alfaro González JV, García Giralda L, Casas I, Sandoval C şi Buitrago L. Managementul calităţii în programul de chirurgie minor în Atenţie primar. Management de Atenţie Primar Din Murcia. Serviciul de Sănătate Murcian. Jurnalul Calităţii Asistenţei Medicale 2004; 19(6):380-7.

36. Graells J, Espinola A, Barrio C, Muñoz MD, Román A, Parellada N. Cirugy minor ambulatoriu dermatologic şi crioterapie. Studiu Studiu comparativ între un dermatolog şi medicii de familie. Actas Dermo-Sifiliográficas 2007; 98(3):171-177.

37. Tárraga López PJ, Marín Nieto E, Garcia Olmo D, Celada Rodríguez A, Solera Albero J, Cerdán Oliver M, şi alţii. Impactul economic al implementării unui program de chirurgie minoră în asistenţa medicală primară. Asistenţă medicală primară. Vol. 27. Nr. 5. Martie 2001.

38. America de Nord Asociaţia de Diagnostic Medical în Asistenţă Medicală (NANDA). Diagnostic medical: Definiţii şi Clasificare 2005-2006. Elsevier. Madrid 2005.

39. McCloskey J, Bulechek G. Clasificarea Intervenţiilor de Asistenţă Medicală (NIC). Elsevier Mosby. Madrid 2005.

40. Moorhead S, Johnson M., maas M.Clasificare de Rezultate de Asistenţă medicală (NOC). Elsevier Mosby. Madrid 2005.

41. Johnson M., Glonţ G, McCloskey J, Maas m, Moorhead s. Diagnosticare Asistente medicale, rezultate şi intervenţii. Interrelaţiile dintre NANDA, NOC şi NIC. Harcourt Mosby. Madrid 2002.

42. López Garcia de Viezma LA. Manual de suturi. Ed. Menarini. Madrid, 2005

43. Manual de chirurgie minor în Atenţie primar. Xunta de Galicia.2005